

- 3) симпатического;
- 4) левого возвратного;
- 5) **правого возвратного.**

Раздел 9. Тестовые задания 9.01–9.559.

**Живот: топография брюшных стенок, этажей живота и забрюшинного пространства.
Операции на органах брюшной полости и забрюшинного пространства**

9.01 (УНВПО) Вентральной грыжей следует называть:

- 1) **выхождение внутренних органов вместе с париетальной брюшиной из брюшной полости через естественные или искусственные отверстия под кожу;**
- 2) выходение внутренних органов из полости живота через повреждённую (разрыв, ранение) стенку брюшной полости;
- 3) **выхождение внутренних органов вместе с париетальной брюшиной через щели в мышечно-апоневротическом слое тазового дна при целостности кожных покровов;**
- 4) выходение из брюшной полости органа или его части, не покрытой брюшиной (например, матки через влагалище);
- 5) **перемещение органов из брюшной в грудную полость через естественные или приобретённые отверстия и щели диафрагмы.**

9.02 (УНВПО) По этиологическому признаку вентральные грыжи классифицируются на:

- 1) **врождённые;**
- 2) **послеоперационные;**
- 3) **травматические;**
- 4) **ущемлённые;**
- 5) **приобретённые.**

9.03 (УНВПО) По этиологическому признаку вентральные грыжи классифицируются на:

- 1) **травматические;**
- 2) **осложнённые;**
- 3) **послеоперационные;**
- 4) **неосложнённые;**
- 5) **рецидивные.**

9.04 (УНВПО) По анатомическому признаку вентральные грыжи принято классифицировать на:

- 1) **паховые;**
- 2) **пупочные;**
- 3) **невправимые;**
- 4) **бедренные;**
- 5) **грыжи белой линии живота.**

9.05 (УНВПО) По анатомическому признаку вентральные грыжи классифицируются на:

- 1) **грыжи белой линии живота;**
- 2) **приобретённые;**
- 3) **грыжи спигелиевой линии;**
- 4) **невправимые;**
- 5) **пупочные.**

9.06 (УНВПО) По анатомическому признаку вентральные грыжи классифицируются на:

- 1) **травматические;**
- 2) **грыжи мечевидного отростка;**
- 3) **ущемлённые;**

- 4) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы;
- 5) косые паховые грыжи.

9.07 (УНВПО) По анатомическому признаку вентральные грыжи классифицируются на:

- 1) промежностные;
- 2) послеоперационные;
- 3) прямые паховые грыжи;
- 4) рецидивные;
- 5) грыжи запирающего отверстия.

9.08 (УНВПО) По анатомическому признаку вентральные грыжи классифицируются на:

- 1) наружные;
- 2) внутренние;
- 3) бедренные;
- 4) рецидивные;
- 5) паховые.

9.09 (УНВПО) К внутренним грыжам относят:

- 1) грыжу запирающего отверстия;
- 2) грыжу пищеводного отверстия диафрагмы;
- 3) промежностную грыжу;
- 4) диафрагмальную грыжу;
- 5) седалищную грыжу.

9.10 (УНВПО) По клиническому течению вентральные грыжи классифицируются на:

- 1) вправимые;
- 2) невправимые;
- 3) приобретённые;
- 4) осложнённые;
- 5) неосложнённые.

9.11 (УНВПО) К осложнённым относят грыжи:

- 1) большие паховые, спускающиеся в мошонку;
- 2) невправимые пупочные;
- 3) гигантские послеоперационные;
- 4) ущемленные;
- 5) выпадающие при малейшем напряжении бедренные.

9.12 (УНВПО) К предрасполагающим факторам образования грыж относят:

- 1) недостаточное общее физическое развитие;
- 2) запоры;
- 3) астеническое телосложение;
- 4) наследственность;
- 5) пол.

9.13 (УНВПО) К производящим факторам образования грыж относят:

- 1) гипертрофию предстательной железы;
- 2) конституциональные особенности;
- 3) истощение;
- 4) опухоли мочевого пузыря;
- 5) беременность.

9.14. (УНВПО) К производящим факторам образования грыж относят:

- 1) хроническое заболевание легких;
- 2) ожирение;
- 3) тяжелый физический труд;
- 4) астеническое телосложение;
- 5) травму брюшной стенки.

9.15 (УНПО) Слабыми участками брюшной стенки являются:

- 1) пупочная область;
- 2) правая паховая область;
- 3) белая линия живота;
- 4) левая паховая область;
- 5) **все варианты верны.**

9.16 (УНВПО) Грыжа называется скользящей, если в грыжевом мешке окажется:

- 1) большой сальник;
- 2) слепая кишка, не покрытая брюшиной со всех сторон;
- 3) стенка мочевого пузыря;
- 4) сигмовидная кишка, не покрытая брюшиной со всех сторон;
- 5) жировая подвеска толстой кишки.

9.17 (УНПО) На врожденную грыжу указывает наличие в грыжевом мешке:

- 1) большого сальника;
- 2) петли тонкой кишки;
- 3) слепой кишки;
- 4) **яичка;**
- 5) стенки мочевого пузыря.

9.18 (УНВПО) Своевременное оперативное лечение ventральных грыж позволяет избежать:

- 1) увеличения размеров грыжевого дефекта;
- 2) образования сложных и гигантских грыж;
- 3) развития невправимой грыжи;
- 4) ущемления грыжи;
- 5) **рецидива грыжи.**

9.19 (УНВПО) Противопоказаниями к оперативному лечению неосложненной грыжи могут быть:

- 1) сердечно-лёгочная недостаточность в стадии декомпенсации;
- 2) активная форма туберкулёза лёгких;
- 3) печеночно-почечная недостаточность;
- 4) облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей;
- 5) **заболевания крови.**

9.20 (УНВПО) Противопоказаниями к оперативному лечению неосложненной грыжи могут быть:

- 1) острое психическое заболевание;
- 2) злокачественное образование;
- 3) варикозное расширение вен нижних конечностей с явлениями тромбофлебита;
- 4) язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии;
- 5) **гнойничковые поражения кожи.**

9.21 (УНПО) Основным методом лечения наружных ventральных грыж является:

- 1) консервативный;
- 2) **хирургический;**

- 3) склерозирующий;
- 4) лучевой;
- 5) комбинированный.

9.22 (УНПО) Операция при грыже должна быть:

- 1) максимально простой;
- 2) достаточно радикальной;
- 3) наименее травматичной;
- 4) безукоризненно технически выполненной;
- 5) **отвечать всем перечисленным выше требованиям.**

9.23 (УНВПО) При выборе способа пластики при грыжесечении необходимо учитывать:

- 1) **вид грыжи;**
- 2) **патогенетические условия её развития;**
- 3) **состояние тканей брюшной стенки;**
- 4) **величину грыжевого дефекта;**
- 5) **пол больного.**

9.24 (УНПО) При ликвидации грыжевого дефекта используются методы пластики:

- 1) фасциально-апоневротический;
- 2) мышечно-апоневротический;
- 3) мышечный;
- 4) пластика с помощью синтетических материалов;
- 5) **все варианты правильны.**

9.25 (УНВПО) Предоперационная подготовка больного с неосложнённой грыжей включает:

- 1) **гигиеническую ванну накануне операции;**
- 2) внутривенное капельное введение солевых растворов и глюкозы;
- 3) **очистительную клизму на ночь;**
- 4) **снотворное на ночь;**
- 5) **тщательное бритьё операционного поля перед операцией.**

9.26 (УНВПО) Развитию рецидивов грыж способствуют:

- 1) **гипертрофия предстательной железы;**
- 2) **хронические запоры;**
- 3) **хронические бронхиты;**
- 4) варикозное расширение вен нижних конечностей;
- 5) **ожирение.**

9.27 (УНПО) К дефектам оперативной техники грыжесечения относят:

- 1) наложение слишком частых или слишком редких швов;
- 2) излишняя травматизация тканей;
- 3) недостаточный гемостаз;
- 4) нарушение анатомичности соединения слоев;
- 5) **все варианты правильны.**

9.28 (УНВПО) Паховый канал образуют следующие анатомические структуры:

- 1) **апоневроз наружной косой мышцы живота;**
- 2) **внутренняя косая мышца;**
- 3) **поперечная мышца;**
- 4) элементы семенного канатика;
- 5) **поперечная фасция.**

9.29 (УНПО) Задней стенкой пахового канала является:

- 1) апоневроз наружной косой мышцы живота;
- 2) паховая связка;
- 3) внутренняя косая мышца живота;
- 4) поперечная мышца;
- 5) **поперечная фасция.**

9.30 (УНПО) Верхней стенкой пахового канала является:

- 1) паховая связка;
- 2) семенной канатик;
- 3) поперечная фасция;
- 4) **свободные края внутренней косой и поперечной мышц живота;**
- 5) апоневроз наружной косой мышцы живота.

9.31 (УНПО) Нижней стенкой пахового канала является:

- 1) поперечная фасция;
- 2) апоневроз наружной косой мышцы живота;
- 3) внутренняя косая мышца живота;
- 4) **паховая связка;**
- 5) поперечная мышца.

9.32 (УНПО) Наружное отверстие пахового канала образовано:

- 1) расслоением внутренней косой мышцы живота;
- 2) **ножками апоневроза наружной косой мышцы живота;**
- 3) кольцом в поперечной фасции;
- 4) краями прямой и внутренней косой мышц живота;
- 5) овальной ямкой на широкой фасции бедра.

9.33 (УНПО) Незаращение брюшинно-пахового отростка является причиной образования:

- 1) приобретённых грыж;
- 2) грыж от усилия;
- 3) грыж от слабости;
- 4) искусственных грыж;
- 5) **врожденных грыж.**

9.34 (УНПО) При установлении диагноза «вентральная грыжа» необходимо учитывать:

- 1) жалобы больного;
- 2) данные анамнеза;
- 3) данные осмотра;
- 4) данные пальпации, перкуссии и аускультации;
- 5) **все перечисленные выше данные.**

9.35 (УНПО) Грыжевой мешок формируется посредством расширения и прогрессивного вытяжения:

- 1) висцеральной брюшины;
- 2) **париетальной брюшины;**
- 3) апоневроза;
- 4) мышц;
- 5) кожи.

9.36 (УНПО) В развитии паховой грыжи выделяют ряд последовательных стадий:

- 1) **начальную;**
- 2) **формирование грыжевого канала;**
- 3) **канальную;**

- 4) канатиковую;
- 5) пахово-мошоночную.

9.37 (УНВПО) Для паховой грыжи характерны следующие клинические признаки:

- 1) наличие грыжевого выпячивания в паховой области;
- 2) уменьшение грыжевого выпячивания при физическом напряжении;
- 3) боли в области грыжевого выпячивания;
- 4) расширение наружного отверстия пахового канала;
- 5) положительный симптом кашлевого толчка.

9.38 (УНВПО) При косой паховой грыже:

- 1) грыжевое выпячивание продолговатой формы;
- 2) грыжевое выпячивание часто опускается в мошонку;
- 3) грыжевое выпячивание чаще двухстороннее;
- 4) грыжевое выпячивание чаще встречается в детском и зрелом возрасте;
- 5) кашлевой толчок ощущается сбоку от элементов канатика.

9.39 (УНВПО) Прямая паховая грыжа:

- 1) чаще встречается в пожилом возрасте;
- 2) исключительно редко опускается в мошонку;
- 3) чаще односторонняя;
- 4) проходит в прямом направлении через паховый промежуток;
- 5) кашлевой толчок ощущается прямо против наружного отверстия пахового канала.

9.40 (УНВПО) Прямая паховая грыжа:

- 1) выходит из брюшной полости через медиальную паховую ямку;
- 2) повторяет ход пахового канала;
- 3) не бывает врождённой;
- 4) располагается кнутри от семенного канатика;
- 5) имеет округлую форму.

9.41 (УНПО) Дифференциальная диагностика паховой грыжи должна проводиться с:

- 1) метастазами опухоли в паховые лимфоузлы;
- 2) паховым лимфаденитом;
- 3) холодным натёчиком;
- 4) орхитом;
- 5) все варианты верны.

9.42 (УНПО) Паховую грыжу необходимо дифференцировать с:

- 1) бедренной грыжей;
- 2) водянкой яичка;
- 3) варикозным расширением вен семенного канатика;
- 4) неопустившимся яичком;
- 5) все варианты верны.

9.43 (УНВПО) Для укрепления задней стенки пахового канала используют способы:

- 1) Постемпского;
- 2) Боброва;
- 3) Кукуджанова;
- 4) Жирара;
- 5) Бассини.

9.44 (УНВПО) Для укрепления передней стенки пахового канала используют способы:

- 1) Бассини;
- 2) Жирара;
- 3) Мартынова;
- 4) Спасокукоцкого;
- 5) Кимбаровского.

9.45 (УНВПО) Грыжесечение по способу Мартынова включает в себя:

- 1) рассечение кожи и подкожной клетчатки;
- 2) рассечение апоневроза наружной косой мышцы;
- 3) выделение и обработку грыжевого мешка;
- 4) подшивание верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы над семенным канатиком к пупартовой связке, а нижний накладывают на верхний и подшивают к нему узловыми швами;
- 5) подшивание края верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы вместе с внутренней косой и поперечной мышцами и поперечной фасцией к пупартовой связке.

9.46 (УНВПО) Грыжесечение по способу Боброва включает в себя:

- 1) рассечение кожи и подкожной клетчатки;
- 2) рассечение апоневроза наружной косой мышцы;
- 3) выделение и обработку грыжевого мешка;
- 4) подшивание края верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы с краями внутренней косой и поперечной мышц к пупартовой связке, нижний лоскут апоневроза накладывают на верхний и подшивают к нему узловыми швами;
- 5) подшивание края верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы вместе с внутренней косой и поперечной мышцами и поперечной фасцией к пупартовой связке.

9.47 (УНВПО) Грыжесечение по способу Спасокукоцкого включает в себя:

- 1) рассечение кожи и подкожной клетчатки;
- 2) рассечение апоневроза наружной косой мышцы;
- 3) выделение и обработку грыжевого мешка;
- 4) подшивание края верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы с краями внутренней косой и поперечной мышц к пупартовой связке, а нижний лоскут апоневроза накладывают на верхний и подшивают к нему узловыми швами;
- 5) подшивание края внутренней косой и поперечной мышц над семенным канатиком к пупартовой связке. Над ними к пупартовой связке подшивают верхний лоскут апоневроза наружной косой мышцы, а нижний лоскут апоневроза накладывают на верхний и подшивают к нему узловыми швами.

9.48 (УНВПО) Грыжесечение с использованием шва Кимбаровского включает в себя:

- 1) рассечение кожи и подкожной клетчатки;
- 2) рассечение апоневроза наружной косой мышцы;
- 3) выделение и обработку грыжевого мешка;
- 4) подшивание верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы над семенным канатиком к пупартовой связке, а нижний лоскут накладывают на верхний и подшивают к нему узловыми швами;
- 5) прошивание верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы в 1 см от его края с пучком подлежащих мышц и возвращением иглы через выкол на апоневрозе у его края; этой же лигатурой прошивают паховую связку. Нижний лоскут апоневроза накладывают на верхний и подшивают к нему узловыми швами.

9.49 (УНВПО) Грыжесечение по Бассини при прямой паховой грыже включает в себя:

- 1) рассечение кожи и подкожной клетчатки;**
- 2) рассечение апоневроза наружной косой мышцы;**
- 3) выделение и обработку грыжевого мешка;**
- 4) подшивание края верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы с внутренней косой и поперечными мышцами к пупартовой связке, над семенным канатиком;
- 5) подшивание под семенным канатиком внутренней косой и поперечной мышц с фасцией к пупартовой связке, сшивание краев апоневроза наружной косой мышцы над семенным канатиком.**

9.50 (УНВПО) Грыжесечение при прямой паховой грыже по Постемпскому включает в себя:

- 1) рассечение кожи и подкожной клетчатки;**
- 2) рассечение апоневроза наружной косой мышцы;**
- 3) выделение и обработку грыжевого мешка;**
- 4) подшивание под семенным канатиком к пупартовой связке верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы вместе с внутренней косой и поперечной мышцами, а нижний лоскут апоневроза накладывается под канатиком на верхний и подшивается к нему узловыми швами;**
- 5) верхний лоскут апоневроза наружной косой мышцы над семенным канатиком подшивают к пупартовой связке,
а нижний лоскут апоневроза накладывают на верхний и подшивают к нему узловыми швами.

9.51 (УНПО) Во время грыжесечения при паховой грыже возможны осложнения:

- 1) повреждение семявыносящего протока;
- 2) захват в шов подвздошно-пахового нерва;
- 3) сужение наружного отверстия пахового канала до 1 см в диаметре;
- 4) повреждение стенки мочевого пузыря или петли кишки;
- 5) все варианты верны.**

9.52 (УНПО) Латеральной границей бедренного кольца является:

- 1) гребешковая фасция;
- 2) бедренная вена;**
- 3) поперечная фасция;
- 4) паховая связка;
- 5) лакунарная связка.

9.53 (УНПО) Передней границей бедренного кольца является:

- 1) гребешковая фасция;
- 2) бедренная вена;
- 3) поперечная фасция;
- 4) паховая связка;**
- 5) лакунарная связка.

9.54 (УНПО) Медиальной границей бедренного кольца является:

- 1) бедренная вена;
- 2) поперечная фасция;
- 3) гребешковая фасция;
- 4) лакунарная связка;**
- 5) паховая связка.

9.55 (УНПО) Задней границей бедренного кольца является:

- 1) поперечная фасция;
- 2) паховая связка;
- 3) гребешковая фасция;**
- 4) лакунарная связка;
- 5) бедренная вена.

9.56 (УНВПО) Характерными клиническими признаками бедренной грыжи являются:

- 1) наличие грыжевого выпячивания под паховой связкой;**
- 2) наличие грыжевого выпячивания выше паховой связки;**
- 3) периодические боли в области грыжевого выпячивания;**
- 4) грыжевое выпячивание небольшого размера;**
- 5) грыжевое выпячивание полусферической формы.**

9.57 (УНПО) Дифференциальный диагноз бедренной грыжи проводят со всем, кроме:

- 1) доброкачественной опухоли;
- 2) метастатической опухоли в лимфоузлы;
- 3) водянки яичка;**
- 4) аневризматического расширения большой подкожной вены у места её впадения в бедренную вену;
- 5) лимфаденита;

9.58 (УНВПО) Для пластики внутреннего отверстия бедренного канала при бедренной грыже используются способы:

- 1) Ру-Оппеля;
- 2) Бассини;**
- 3) Постемпского;
- 4) Мартынова;
- 5) Руджи.**

9.59 (УНВПО) Грыжесечение по способу Бассини при бедренной грыже включает в себя:

- 1) рассечение бедренным доступом кожи и подкожной клетчатки;**
- 2) выделение грыжевого мешка;**
- 3) вскрытие грыжевого мешка, прошивание его у шейки и отсечение;**
- 4) закрытие внутреннего отверстия бедренного канала тремя швами, которыми сшивают задний и нижний края паховой связки с надкостницей лонной кости, а затем соединяют край овальной ямки с гребешковой фасцией и гребешковой мышцей;**
- 5) фиксация паховой связки одной шёлковой лигатурой, проведённой вокруг горизонтальной ветви лобковой кости.

9.60 (УНВПО) При пупочных грыжах применяют пластику по способам:

- 1) Лексера;**
- 2) Руджи;
- 3) Бассини;
- 4) Сапежко;**
- 5) Мейо.**

9.61 (УНВПО) Пластика пупочной грыжи по способу Сапежко включает в себя:

- 1) рассечение кожи и подкожной клетчатки;**
- 2) выделение грыжевого мешка;**
- 3) рассечение и перевязку грыжевого мешка;**

- 4) ушивание грыжевых ворот кисетным швом;
- 5) ушивание грыжевых ворот дубликатурой апоневроза в вертикальном направлении.

9.62 (УНВПО) По механизму развития различают следующие виды ущемления вентральных грыж:

- 1) эластическое;
- 2) каловое;
- 3) пристеночное;
- 4) ретроградное;
- 5) ущемление дивертикула Меккеля.

9.63 (УНВПО) Клиническими признаками ущемлённой грыжи являются:

- 1) внезапно возникшая резкая боль в области грыжевого выпячивания;
- 2) невосприимчивость грыжи;
- 3) отсутствие напряжения грыжевого выпячивания;
- 4) отсутствие передачи кашлевого толчка;
- 5) явления кишечной непроходимости.

9.64 (УНПО) Для невосприимчивой паховой грыжи характерно:

- 1) резкая боль в области грыжевого выпячивания;
- 2) рвота;
- 3) тахикардия;
- 4) невозможность полного вправления грыжевого содержимого;
- 5) явления кишечной непроходимости.

9.65 (УНПО) Клиническая картина ущемлённой грыжи не зависит от:

- 1) вида грыжи;
- 2) механизма развития ущемления;
- 3) времени, прошедшего от момента ущемления;
- 4) вида ущемлённого органа;
- 5) наличия или отсутствия сопутствующей патологии.

9.66 (УНПО) Из перечисленных действий хирурга при выполнении операции грыжесечения по поводу ущемленной грыжи факт ущемления подтверждает:

- 1) выделение грыжевого мешка;
- 2) ревизия грыжевого содержимого;
- 3) фиксация грыжевого содержимого на турникете;
- 4) вправление грыжевого содержимого в брюшную полость;
- 5) прошивание грыжевого мешка у шейки и его отсечение.

9.67 (УНПО) При формировании скользящей грыжи стенку грыжевого мешка могут составлять все органы, за исключением:

- 1) восходящего отдела толстой кишки;
- 2) нисходящего отдела толстой кишки;
- 3) слепой кишки;
- 4) мочевого пузыря;
- 5) тощей кишки.

9.68 (УНПО) При формировании скользящей грыжи стенку грыжевого мешка могут составлять органы:

- 1) тощая кишка;
- 2) большой сальник;

- 3) поперечно-ободочная кишка;
- 4) сигмовидная кишка;
- 5) ни один из вариантов.**

9.69 (УНПО) При грыжесечении по поводу паховой скользящей грыжи после вскрытия грыжевого мешка и ревизии в первую очередь необходимо выполнить:

- 1) рассечение грыжевых ворот;
- 2) ушивание грыжевого мешка;
- 3) вправление грыжевого содержимого и его фиксацию;**
- 4) прошивание у шейки и иссечение грыжевого мешка;
- 5) пластику грыжевых ворот.

9.70 (УНПО) При косой приобретенной паховой грыже элементы семенного канатика по отношению к грыжевому мешку находятся:

- 1) латерально;
- 2) спереди;
- 3) медиально;**
- 4) сзади;
- 5) внутри мешка.

9.71 (УНПО) При прямой приобретенной паховой грыже элементы семенного канатика по отношению к грыжевому мешку находятся:

- 1) латерально;**
- 2) медиально;
- 3) сзади;
- 4) спереди;
- 5) внутри мешка.

9.72 (УНПО) При операции грыжесечения по поводу врожденной паховой грыжи следующим действием хирурга после ревизии и вправлении грыжевого содержимого будет:

- 1) рассечение грыжевых ворот;
- 2) прошивание шейки грыжевого мешка без его отсечения;**
- 3) обработка грыжевого мешка по Винкельману;
- 4) прошивание шейки грыжевого мешка и его отсечение;
- 5) пластика пахового канала.

9.73 (УНПО) При операции грыжесечения по поводу врожденной паховой грыжи следующим действием хирурга после пластики пахового канала будет:

- 1) выделение и вскрытие грыжевого мешка;
- 2) осмотр и вправление содержимого в брюшную полость
- 3) иссечение оболочек мешка на семенном канатике;
- 4) послойного зашивания раны;**
- 5) прошивание шейки грыжевого мешка и его отсечение.

9.74 (УНПО) При пластике пупочного кольца при пупочной грыже методом Мейо соединяют следующие ткани:

- 1) правый и левый края апоневроза широких мышц живота;
- 2) верхний и нижний края апоневроза широких мышц живота;**
- 3) внутренние края прямой мышцы живота;
- 4) внутренние края апоневроза наружной косой мышцы живота;
- 5) внутренние края собственной фасции пупочной области.

9.75 (УНПО) При пластике пупочного кольца при пупочной грыже методом Сапежко соединяют следующие ткани:

- 1) внутренние края прямой мышцы живота;
- 2) верхний и нижний края апоневроза трех широких мышц живота;
- 3) внутренние края апоневроза трех широких мышц живота;**
- 4) внутренние края апоневроза внутренней косой мышцы живота;
- 5) внутренние края апоневроза наружной косой мышцы живота;

9.76 (УНПО) При выполнении операции грыжесечения паховой грыжи следующим действием хирурга после оперативного доступа будет:

- 1) прошивание шейки грыжевого мешка и его отсечение;
- 2) выделение грыжевого мешка;**
- 3) вскрытие грыжевого мешка;
- 4) осмотр грыжевого содержимого и вправление его в брюшную полость;
- 5) пластика пахового канала;

9.77 (УНПО) При выполнении операции грыжесечения приобретенной паховой грыжи следующим действием хирурга после осмотра грыжевого содержимого будет:

- 1) оперативный доступ;
- 2) вскрытие грыжевого мешка;
- 3) вправление грыжевого содержимого;**
- 4) прошивание шейки с последующим отсечением грыжевого мешка;
- 5) пластика пахового канала.

9.78 (УНПО) При выполнении операции грыжесечения приобретенной паховой грыжи следующим действием хирурга после вскрытия грыжевого мешка будет:

- 1) ревизия грыжевого содержимого;**
- 2) выделение грыжевого мешка;
- 3) вправление грыжевого содержимого;
- 4) прошивание шейки грыжевого мешка и его отсечение;
- 5) пластика пахового канала.

9.79 (УНПО) При выполнении операции грыжесечения по поводу ущемленной паховой грыжи следующим действием хирурга после фиксации грыжевого содержимого будет:

- 1) оперативный доступ;
- 2) выделение грыжевого мешка;
- 3) вскрытие грыжевого мешка и осмотр содержимого;
- 4) рассечение ущемляющего кольца;**
- 5) оценка жизнеспособности грыжевого содержимого и вправление его в брюшную полость.

9.80 (УНПО) При пластике пахового канала по Краснобаеву выполняют:

- 1) рассечение апоневроза наружной косой мышцы живота и создание из него дубликатуры;
- 2) создание дубликатуры из апоневроза наружной косой мышцы живота без предварительного его рассечения;**
- 3) суживание только наружного пахового кольца;
- 4) суживание только пахового промежутка;
- 5) ни один из вариантов.

9.81 (УНПО) При пластике пахового канала по Ру-Оппелю выполняют:

- 1) рассечение апоневроза наружной косой мышцы и создание из него дубликатуры;
- 2) создание дубликатуры из апоневроза наружной косой мышцы без рассечения последнего;

- 3) сужение только наружного пахового кольца;
- 4) укрепление задней стенки канала;
- 5) укрепление передней и задней стенок канала.

9.82 (УНПО) При пластике пахового канала по Мартынову выполняют:

- 1) укрепление задней стенки пахового канала после рассечения передней;
- 2) укрепление передней стенки пахового канала без ее рассечения;
- 3) сшивание листков рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота конец в конец;
- 4) **сшивание листков рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота с образованием дубликатуры;**
- 5) подшивание верхнего листка рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота к паховой связке.

9.83 (УНПО) При пластике пахового канала по Кимбаровскому во второй ряд швов захватывают:

- 1) внутреннюю косую мышцу живота и паховую связку;
- 2) поперечную мышцу живота и паховую связку;
- 3) поперечную фасцию и паховую связку;
- 4) оба листка апоневроза наружной косой мышцы живота;
- 5) **ни один из вариантов.**

9.84 (УНПО) При пластике бедренного канала по Бассини сшивают его стенки:

- 1) ниже-заднюю и медиальную;
- 2) ниже-заднюю и латеральную;
- 3) латеральную и медиальную;
- 4) **передне-верхнюю и ниже-заднюю;**
- 5) передне-верхнюю и медиальную.

9.85 (УНПО) При пластике бедренного канала по Бассини используют все ткани, кроме:

- 1) паховой связки;
- 2) **лакунарной связки;**
- 3) надкостницы лобковой кости;
- 4) влагалища бедренной вены;
- 5) подвздошно-поясничной мышцы.

9.86 (УНПО) «Корона смерти» в области внутреннего бедренного кольца, как правило, формируется в области:

- 1) верхней границы;
- 2) нижней границы;
- 3) латеральной границы;
- 4) **медиальной границы;**
- 5) ни один из вариантов.

9.87 (УНПО) «Корона смерти» – это вариант отхождения артерии:

- 1) бедренной;
- 2) надчревной нижней;
- 3) надчревной верхней;
- 4) **запирательной;**
- 5) внутренней подвздошной.

9.88 (УНПО) При пластике бедренного канала по Руджи сшивают стенки внутреннего бедренного кольца:

- 1) **верхне-переднюю и задне-нижнюю;**
- 2) латеральную и медиальную;
- 3) латеральную и задне-нижнюю;
- 4) латеральную и верхне-переднюю;
- 5) медиальную и верхне-переднюю.

9.89 (УНПО) При пластике бедренного канала по Руджи сшивают:

- 1) паховую связку и подвздошно-поясничную мышцу;
- 2) **паховую связку и гребешковую связку;**
- 3) лакунарную связку и надкостницу лобковой кости;
- 4) лакунарную связку и влагалище бедренной вены;
- 5) паховую связку и лакунарную связку.

9.90 (УНПО) При оперативном доступе по Бассини по поводу бедренной грыжи рассекают все ткани, кроме:

- 1) поверхностной фасции бедра;
- 2) поверхностного листка широкой фасции бедра;
- 3) **гребешковой связки;**
- 4) **паховой связки;**
- 5) **глубокого листка широкой фасции бедра.**

9.91 (УНПО) При выполнении грыжесечения по Мартынову оперативный доступ осуществляют, рассекая все ткани, кроме:

- 1) собственной фасции области;
- 2) апоневроза наружной косой мышцы живота;
- 3) поверхностной фасции области;
- 4) **внутренней косой мышцы живота;**
- 5) ни один из вариантов.

9.92 (УНПО) При оперативном доступе при выполнении грыжесечения по Руджи рассекают все ткани, кроме:

- 1) кожи и подкожной клетчатки в паховой области;
- 2) **кожи и подкожной клетчатки в области передней поверхности верхней трети бедра;**
- 3) апоневроза наружной косой мышцы живота;
- 4) внутренней косой мышцы живота;
- 5) поперечной фасции.

9.93 (УНПО) При выполнении пластики бедренного канала по Руджи-Парлавеччо в шов захватывают все ткани, кроме:

- 1) внутренней косой мышцы живота;
- 2) поперечной мышцы живота;
- 3) поперечной фасции;
- 4) паховой связки;
- 5) **ни один из вариантов.**

9.94 (УНПО) При выполнении пластики бедренного канала по Руджи-Парлавеччо в шов захватывают все ткани, кроме:

- 1) паховой связки;
- 2) гребешковой связки;
- 3) внутренней косой мышцы живота;
- 4) поперечной фасции;
- 5) **брюшины.**

9.95 (УНПО) При выполнении пластики пупочного кольца по Лексеру по поводу пупочной грыжи в шов захватывают:

- 1) медиальные края прямой мышцы живота;
- 2) края собственной фасции;
- 3) края поверхностной фасции;
- 4) края апоневрозов трех широких мышц живота;**
- 5) края апоневроза внутренней косой мышцы живота.

9.96 (УНВПО) Образование, составляющее заднюю стенку влагалища m. rectus выше пупочного кольца, представляет собой:

- 1) поперечную фасцию;
- 2) париетальную брюшину;
- 3) апоневроз наружной косой мышцы живота;
- 4) задний листок апоневроза внутренней косой мышцы живота;**
- 5) апоневроз поперечной мышцы.**

9.97 (УНПО) Образование, составляющее заднюю стенку влагалища m. rectus ниже пупочного кольца, представляет собой:

- 1) поперечную фасцию;**
- 2) париетальную брюшину;
- 3) апоневроз внутренней косой мышцы живота;
- 4) апоневроз поперечной мышцы;
- 5) апоневроз наружной косой мышцы живота.

9.98 (УНПО) В паховой области спереди апоневроза наружной косой мышцы живота находится:

- 1) подкожно-жировая клетчатка;
- 2) подфасциальная жировая клетчатка;
- 3) Томпсонова пластинка;**
- 4) поверхностная фасция;
- 5) апоневроз внутренней косой мышцы живота.

9.99 (УНПО) Нижнюю стенку пахового канала составляет:

- 1) нижний край наружной косой мышцы живота;
- 2) паховая связка;**
- 3) латеральный край прямой мышцы живота;
- 4) медиальный край прямой мышцы живота;
- 5) свободные нижние края внутренней косой и поперечной мышц живота.

9.100 (УНПО) Нижняя и верхняя надчревные артерии передней брюшной стенки находятся:

- 1) позади апоневроза наружной косой мышцы живота;
- 2) позади апоневроза внутренней косой мышцы живота;
- 3) позади апоневроза поперечной мышцы живота;
- 4) позади прямой мышцы живота в предбрюшинной клетчатке;**
- 5) в подкожно-жировой клетчатке.

9.101 (УНПО) Переднюю стенку пахового канала составляет:

- 1) Томпсонова пластинка;
- 2) апоневроз наружной косой мышцы живота;**
- 3) семенной канатик;
- 4) паховая связка;
- 5) апоневроз внутренней косой мышцы живота.

9.102 (УНПО) Заднюю стенку пахового канала составляет:

- 1) **поперечная фасция;**
- 2) поперечная мышца живота;
- 3) внутренняя косая мышца живота;
- 4) брюшина;
- 5) предбрюшинная клетчатка.

9.103 (УНПО) В паховом канале к семенному канатику снизу прилежит нерв:

- 1) XII подреберный;
- 2) **подвздошно-паховый;**
- 3) подвздошно-подчревный;
- 4) половое-бедренный,
- 5) бедренный.

9.104 (УНПО) Иннервацию пупочной области передней брюшной стенки осуществляют:

- 1) чревное сплетение;
- 2) VII-IX межреберные нервы;
- 3) **IX-XI межреберные нервы;**
- 4) X-XII межреберные нервы;
- 5) подвздошно-подчревный нерв.

9.105 (УНПО) Иннервацию собственно надчревной области передней брюшной стенки осуществляют:

- 1) подвздошно-паховый, подвздошно-подчревный и XI-XII межреберные нервы;
- 2) подвздошно-паховый и подвздошно-подчревный нервы;
- 3) **VII-IX межреберные нервы;**
- 4) нижнее подчревное сплетение;
- 5) верхнее подчревное сплетение.

9.106 (УНПО) В области пупочного кольца передняя брюшная стенка представлена:

- 1) **кожей, пупочной фасцией и брюшиной;**
- 2) кожей, подкожной клетчаткой, апоневрозом поперечной мышцы живота;
- 3) кожей, апоневрозом наружной косой мышцы живота, брюшиной;
- 4) кожей и брюшиной;
- 5) только кожей.

9.107 (УНПО) При пластике пахового канала по Мартынову укрепляют стенку:

- 1) заднюю;
- 2) верхнюю;
- 3) заднюю и верхнюю;
- 4) **переднюю;**
- 5) нижнюю.

9.108 (УНПО) При пластике пахового канала по Спасокукоцкому укрепляют его стенку:

- 1) **переднюю;**
- 2) заднюю;
- 3) заднюю и верхнюю;
- 4) нижнюю;
- 5) верхнюю.

9.109 (УНПО) При выполнении собственно грыжесечения иссекают:

- 1) поперечную мышцу живота;
- 2) наружную косую мышцу живота;
- 3) внутреннюю косую мышцу живота;

- 4) поперечную фасцию;
- 5) брюшину.**

9.110 (УНПО) При пластике пахового канала по Бассини в первый ряд швов захватывают следующие ткани:

- 1) апоневроз наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 2) внутреннюю и наружную косые мышцы живота;
- 3) внутреннюю косую мышцу живота и поперечную фасцию;
- 4) поперечную фасцию и паховую связку;
- 5) ни один из вариантов.**

9.111 (УНПО) При приобретенной косой паховой грыже элементы семенного канатика по отношению к оболочкам грыжевого мешка:

- 1) плотно спаяны;
- 2) рыхло прилежат друг к другу;**
- 3) отделены друг от друга;
- 4) отделены широкой мышцей живота;
- 5) ни один из вариантов.

9.112 (УНПО) При врожденной паховой грыже элементы семенного канатика по отношению к оболочкам грыжевого мешка:

- 1) плотно спаяны;**
- 2) рыхло прилежат друг к другу;
- 3) отделены друг от друга;
- 4) отделены поперечной фасцией;
- 5) ни один из вариантов.

9.113 (УНПО) При грыже Литтре в грыжевой мешок попадает:

- 1) слепая кишка с аппендикулярным отростком;
- 2) аппендикулярный отросток;
- 3) дивертикул Меккеля;**
- 4) стенка толстой кишки;
- 5) стенка тонкой кишки.

9.114 (УНПО) При грыже Рихтера в грыжевой мешок попадает:

- 1) аппендикулярный отросток;
- 2) дивертикул Меккеля;
- 3) мочевого пузыря;
- 4) стенка кишки;**
- 5) петля тонкой кишки.

9.115 (УНПО) При ретроградном ущемлении (грыже типа «W») в грыжевом мешке обнаруживают:

- 1) петлю тонкой кишки;
- 2) петлю толстой кишки;
- 3) большой сальник;
- 4) несколько петель тонкой кишки;**
- 5) ни один из вариантов.

9.116 (УНПО) Попеременный оперативный доступ к органам брюшной полости предполагает:

- 1) рассечение всех тканей брюшной стенки послойно в одной плоскости;
- 2) рассечение всех тканей брюшной стенки одним слоем в одной плоскости;
- 3) рассечение всех тканей брюшной стенки послойно в разных плоскостях;**
- 4) нанесение нескольких кожных разрезов на брюшной стенке;

5) ни один из вариантов.

9.117 (УНПО) При пластике пахового канала по Бассини в первый ряд швов захватывают:

- 1) **внутреннюю косую, поперечную мышцы живота, поперечную фасцию и паховую связку;**
- 2) латеральный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 3) медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 4) латеральный и медиальный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (дубликатура);
- 5) ни один из вариантов.

9.118 (УНПО) При пластике пахового канала по Бассини во второй ряд швов захватывают:

- 1) внутреннюю косую мышцу живота и паховую связку;
- 2) медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и внутреннюю косую мышцу живота;
- 3) **медиальный и латеральный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (конец в конец);**
- 4) поперечную фасцию, поперечную мышцу и паховую связку;
- 5) внутреннюю косую, поперечную мышцы живота и влагалище прямой мышцы.

9.119 (УНВПО) При пластике пахового канала по Мартынову используют все ткани, кроме:

- 1) апоневроза наружной косой мышцы живота;
- 2) **внутренней косой мышцы живота;**
- 3) **поперечной мышцы живота;**
- 4) паховой связки;
- 5) **поперечной фасции.**

9.120 (УНПО) При пластике пахового канала по Жирару используют все ткани, кроме:

- 1) паховой связки;
- 2) **поперечной фасции;**
- 3) поперечной мышцы;
- 4) наружной косой мышцы живота;
- 5) внутренней косой мышцы живота.

9.121 (УНПО) При пластике пахового канала по Бассини-Кукуджанову используют все ткани, кроме:

- 1) паховой связки;
- 2) апоневроза наружной косой мышцы живота;
- 3) внутренней косой мышцы живота;
- 4) поперечной фасции;
- 5) **гребешковой связки.**

9.122 (УНВПО) При пластике пахового канала по Краснобаеву используют все ткани, кроме:

- 1) паховой связки;
- 2) апоневроза наружной косой мышцы живота;
- 3) **внутренней косой мышцы живота;**
- 4) **поперечной мышцы живота;**
- 5) **поперечной фасции.**

9.123 (УНПО) При пластике пахового канала по Ру-Оппелю используют следующие ткани:

- 1) **апоневроз наружной косой мышцы живота;**
- 2) внутреннюю косую мышцу живота;
- 3) поперечную мышцу живота;
- 4) влагалище прямой мышцы живота;

5) ни один из вариантов.

9.124 (УНПО) При пластике пахового канала по Спасокукоцкому используют все ткани, кроме:

- 1) поперечной мышцы живота;
- 2) паховой связки;
- 3) внутренней косой мышцы живота;
- 4) наружной косой мышцы живота;
- 5) ни один из вариантов.**

9.125 (УНПО) При пластике пахового канала по Бассини используют все ткани, кроме:

- 1) наружной косой мышцы живота;
- 2) паховой связки;
- 3) внутренней косой мышцы живота;
- 4) поперечной мышцы;
- 5) ни один из вариантов.**

9.126 (УНПО) Длина бедренного канала при сформировавшейся бедренной грыже зависит от:

- 1) задней стенки;
- 2) передней стенки;**
- 3) латеральной стенки;
- 4) медиальной стенки;
- 5) верхней стенки.

9.127 (УНПО) Передней стенкой бедренного канала является:

- 1) бедренная вена;
- 2) бедренная артерия;
- 3) глубокий листок широкой фасции бедра;
- 4) поверхностный листок широкой фасции бедра;**
- 5) гребешковая фасция.

9.128 (УНПО) Заднюю стенку бедренного канала составляет:

- 1) бедренная вена;
- 2) бедренный нерв;
- 3) поверхностный листок широкой фасции бедра;
- 4) гребешковая фасция;**
- 5) паховая связка.

9.129 (УНПО) Задне-нижнюю стенку внутреннего бедренного кольца составляет:

- 1) влагалище бедренной вены;
- 2) гребенчатая связка (связка Купера);**
- 3) паховая связка;
- 4) влагалище бедренной артерии;
- 5) ни один из вариантов.

9.130 (УНПО) Медиальную стенку внутреннего бедренного кольца составляет:

- 1) влагалище бедренной вены;
- 2) паховая связка;
- 3) лакунарная связка (Жимбернатова);**
- 4) края внутренней косой и поперечной мышц живота;
- 5) влагалище прямой мышцы живота.

9.131 (УНПО) Верхнюю границу наружного бедренного кольца составляет:

- 1) гребешковая фасция;
- 2) паховая связка;

- 3) пояснично-подвздошная мышца;
- 4) свободные края внутренней косой и поперечной мышц;
- 5) верхний рог серповидного края широкой фасции бедра.**

9.132 (УНПО) Нижнюю границу наружного бедренного кольца составляет:

- 1) гребешковая мышца;
- 2) влагалище бедренной вены;
- 3) паховая связка;
- 4) нижний рог серповидного края широкой фасции бедра;**
- 5) ни один из вариантов.

9.133 (УНПО) При пластике пахового канала по Спасокукоцкому во второй ряд швов захватывают:

- 1) латеральный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 2) медиальный и латеральный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (с созданием дубликатуры);**
- 3) медиальный и латеральный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (со стыковкой краев конец в конец);
- 4) медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 5) внутреннюю косую и поперечную мышцы живота и паховую связку.

9.134 (УНПО) При пластике пахового канала по Кимбаровскому в первый ряд швов захватывают все ткани, кроме:

- 1) медиального листка апоневроза наружной косой мышцы живота;
- 2) латерального листка апоневроза наружной косой мышцы живота;**
- 3) внутренней косой мышцы живота;
- 4) поперечной мышцы живота;
- 5) поперечной фасции.

9.135 (УНПО) При пластике пахового канала по Кимбаровскому во второй ряд швов захватывают:

- 1) латеральный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 2) медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 3) латеральный и медиальный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (конец в конец);
- 4) медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы, внутреннюю косую и поперечную мышцы живота и паховую связку;
- 5) латеральный и медиальный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (дубликатура).**

9.136 (УНПО) При пластике пахового канала по Бассини в первый ряд швов захватывают:

- 1) латеральный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 2) медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку позади семенного канатика;
- 3) медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и поперечную фасцию позади семенного канатика;
- 4) внутреннюю косую, поперечную мышцы живота и поперечную фасцию позади семенного канатика;
- 5) внутреннюю косую и поперечную мышцы живота и паховую связку позади семенного канатика.**

9.137 (УНПО) При пластике пахового канала по Жирану в первый ряд швов захватывают:

- 1) внутреннюю косую мышцу живота и паховую связку;
- 2) поперечную мышцу живота и паховую связку;

- 3) наружную косую мышцу живота (медиальный листок) и паховую связку;
- 4) наружную косую мышцу живота (латеральный листок) и паховую связку;
- 5) **ни один из вариантов.**

9.138 (УНПО) При пластике пахового канала по Жирану во второй ряд швов захватывают:

- 1) латеральный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 2) **медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;**
- 3) внутреннюю косую мышцу живота и паховую связку;
- 4) глубокий листок поверхностной фасции паховой области (Томпсона пластинка) и паховую связку;
- 5) латеральный и медиальный листки апоневроза наружной косой мышцы живота.

9.139 (УНПО) При пластике пахового канала по Жирану в третий ряд швов захватывают:

- 1) **латеральный и медиальный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (дубликатура);**
- 2) латеральный и медиальный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (конец в конец);
- 3) латеральный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 4) медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 5) **ни один из вариантов.**

9.140 (УНПО) При пластике пахового канала по Мартынову в первый ряд швов захватывают:

- 1) латеральный и медиальный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (конец в конец);
- 2) латеральный и медиальный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (дубликатура);
- 3) **медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;**
- 4) внутреннюю косую мышцу живота и паховую связку;
- 5) внутреннюю косую и поперечную мышцы живота и паховую связку.

9.141 (УНПО) При пластике пахового канала по Мартынову во второй ряд швов захватывают:

- 1) латеральный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 2) латеральный и медиальный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (конец в конец);
- 3) **латеральный и медиальный листки апоневроза наружной косой мышцы живота (дубликатура);**
- 4) медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 5) **ни один из вариантов.**

9.142 (УНПО) При пластике пахового канала по Спасокукоцкому в первый ряд швов захватывают:

- 1) **наружную косую (или медиальный листок ее апоневроза), внутреннюю косую и поперечную мышцы живота и паховую связку;**
- 2) внутреннюю косую мышцу живота и паховую связку;
- 3) медиальный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 4) латеральный листок апоневроза наружной косой мышцы живота и паховую связку;
- 5) внутреннюю косую и поперечную мышцы живота и паховую связку.

9.143 (УНПО) При сшивании концов пищевода проведение иглы через все слои должно производиться под углом к ране:

- 1) меньше 90 градусов;
- 2) больше 90 градусов;
- 3) 90 градусов;
- 4) 90 градусов и меньше 90 градусов;
- 5) не имеет значения.

9.144 (УНПО) При сшивании стенок желудка проведение иглы через все слои должно производиться под углом к ране:

- 1) меньше 90 градусов;
- 2) **больше 90 градусов;**
- 3) 90 градусов;
- 4) 90 градусов и меньше 90 градусов;
- 5) не имеет значения.

9.145 (УНПО) При наложении только одного ряда швов на рану кишки по Ламберу существует опасность:

- 1) внутрикишечного кровотечения;
- 2) «фитильной» инфекции;
- 3) изъязвления слизистой;
- 4) внутрикишечного кровотечения и «фитильной» инфекции;
- 5) **внутрикишечного кровотечения и изъязвления слизистой.**

9.146 (УНПО) При наложении только одного ряда швов на рану кишки по Пирогову существует опасность:

- 1) «фитильной» инфекции;
- 2) внутрикишечного кровотечения;
- 3) изъязвления слизистой;
- 4) **изъязвления слизистой и «фитильной» инфекции;**
- 5) внутрикишечного кровотечения и изъязвления слизистой.

9.147 (УНПО) При наложении только одного ряда швов на рану кишки по Биру существует опасность:

- 1) внутрикишечного кровотечения;
- 2) «фитильной» инфекции;
- 3) изъязвления слизистой;
- 4) внутрикишечного кровотечения и «фитильной» инфекции;
- 5) **внутрикишечного кровотечения и изъязвления слизистой.**

9.148 (УНПО) При наложении только одного ряда швов на рану кишки по Корабельникову-Матешуку существует опасность:

- 1) внутрикишечного кровотечения;
- 2) «фитильной» инфекции;
- 3) изъязвления слизистой;
- 4) **«фитильной» инфекции и изъязвления слизистой;**
- 5) внутрикишечного кровотечения и «фитильной» инфекции.

9.149 (УНПО) При наложении только одного ряда швов на рану кишки по Шмидену существует опасность:

- 1) внутрикишечного кровотечения;
- 2) **«фитильной» инфекции;**
- 3) изъязвления слизистой,
- 4) внутрикишечного кровотечения и «фитильной» инфекции;
- 5) «фитильной» инфекции и изъязвления слизистой.

9.150 (УНПО) При наложении только одного ряда швов на рану кишки по Жели существует опасность:

- 1) изъязвления слизистой и «фитильной» инфекции;
- 2) внутрикишечного кровотечения и «фитильной» инфекции;
- 3) изъязвления слизистой;
- 4) «фитильной» инфекции;**
- 5) внутрикишечного кровотечения.

9.151 (УНПО) Желчный пузырь при выполнении холецистэктомии по поводу калькулезного холецистита при возникновении оснований для ревизии желчного протока:

- 1) удаляют до холедохотомии;
- 2) удаляют после холедохотомии;**
- 3) не удаляют;
- 4) дренируют наружу;
- 5) не имеет ни какого значения.

9.152 (УНПО) При дренировании желчного протока по Пиковскому дренажную трубку вводят в направлении:

- 1) общего печеночного протока через культю пузырного протока;
- 2) общего печеночного протока через разрез желчного протока;
- 3) 12-перстной кишки через разрез желчного протока;**
- 4) 12-перстной кишки через разрез желчного пузыря;
- 5) 12-перстной кишки через культю пузырного протока.

9.153 (УНПО) При дренировании желчного протока по Вишневскому дренажную трубку вводят в направлении:

- 1) общего печеночного протока через культю пузырного протока;
- 2) общего печеночного протока через разрез желчного протока;**
- 3) 12-перстной кишки через разрез желчного протока;
- 4) 12-перстной кишки через разрез желчного пузыря;
- 5) 12-перстной кишки через культю пузырного протока;

9.154 (УНПО) При дренировании желчного протока по Керу дренажную трубку вводят в направлении:

- 1) общего печеночного протока и 12-перстной кишки через культю пузырного протока;
- 2) общего печеночного протока и 12-перстной кишки через разрез желчного протока;**
- 3) общего печеночного протока через разрез желчного протока;
- 4) 12-перстной кишки через разрез желчного протока;
- 5) 12-перстной кишки через культю пузырного протока.

9.155 (УНПО) При выполнении холецистодуоденостомии при непроходимости желчного протока используют технику:

- 1) однорядного кишечного шва;
- 2) двухрядного кишечного шва;**
- 3) трехрядного кишечного шва;
- 4) сосудистого шва;
- 5) любую из перечисленных.

9.156 (УНПО) При сшивании стенок тонкой или толстой кишки проведение иглы через все слои производится под углом к ране:

- 1) 90 градусов;**
- 2) больше 90 градусов;
- 3) меньше 90 градусов;

- 4) 90 градусов и меньше 90 градусов;
- 5) не имеет значения.

9.157 (УНПО) Холедохотомия может применяться во всех случаях, кроме:

- 1) калькулезного холецистита;
- 2) выраженного холангита;
- 3) наличия конкрементов в фатеровом сосочке;
- 4) зондирования внепеченочных желчных путей;
- 5) ни один из вариантов.**

9.158 (УНПО) При выполнении холецистостомии, стенку желчного пузыря вокруг дренажной трубки фиксируют к слоям брюшной стенки:

- 1) париетальной брюшине;**
- 2) париетальной брюшине и коже;
- 3) апоневрозу наружной косой мышцы живота;
- 4) коже;
- 5) внутренней косой мышце живота и коже.

9.159 (УНПО) При выполнении холецистостомии дренажную трубку фиксируют к:

- 1) желчному пузырю;
- 2) желчному пузырю и коже;**
- 3) желчному, пузырю и париетальной брюшине;
- 4) желчному пузырю и апоневрозу наружной косой мышцы живота;
- 5) желчном пузыре и внутренней косой мышце живота.

9.160 (УНПО) При проведении реконструктивных желчеотводящих операций можно наложить все анастомозы, за исключением:

- 1) холецистодуоденостомии;
- 2) холецистогастростомии;
- 3) холецистоеюностомии;
- 4) гепатоеюностомии;
- 5) ни один из вариантов.**

9.161 (УНПО) При выполнении билиодигестивных анастомозов при сдавлении Фатерова сосочка опухолью хирург может выполнить все операции за исключением:

- 1) холецистодуоденостомии;
- 2) холедоходуоденостомии;
- 3) гепатодуоденостомии;
- 4) гепатикоеюностомии;
- 5) ни один из вариантов.**

9.162 (УНПО) После выполненной правосторонней гемиколэктомии в результате странгуляционного некроза необходимо сформировать:

- 1) илеотрансверзоанастомоз конец в бок;
- 2) илеотрансверзоанастомоз конец в конец;
- 3) илеотрансверзоанастомоз бок в бок антиперистальтически;**
- 4) илеотрансверзоанастомоз бок в бок изоперистальтически;
- 5) ни один из вариантов.

9.163 (УНПО) При выполнении экстренной сигмостомии по поводу острой кишечной непроходимости хирург фиксирует края париетальной брюшины к коже с целью:

- 1) лучшего обзора в операционной ране;
- 2) предупреждения инфицирования брюшной полости;
- 3) предупреждения инфицирования подкожно-жировой клетчатки;**
- 4) формирования отверстия стомы;
- 5) создания неподвижного положения стомы.

9.164 (УНВПО) При выполнении экстренной сигмостомии по поводу острой кишечной непроходимости хирург фиксирует париетальную брюшину к висцеральной с целью:

- 1) создания неподвижного положения стомы;**
- 2) предупреждения инфицирования подкожной жировой клетчатки;
- 3) предупреждения инфицирования брюшной полости;**
- 4) формирования отверстия стомы;
- 5) ни один из вариантов.

9.165 (УНПО) При наложении искусственного заднего прохода при неоперабельном раке прямой кишки предполагается:

- 1) выведение петли сигмовидной кишки с отделенной брыжейкой на кожу с последующим отсечением обоих колен (двуствольный свищ);
- 2) выведение петли сигмовидной кишки с цельной брыжейкой на кожу с последующим отсечением обоих колен (двуствольный свищ);
- 3) выведение петли сигмовидной кишки с соединенными коленами (с разделяющей «шпорой») на кожу с последующим отсечением обоих колен (двуствольный свищ)
- 4) глухое зашивание орального отрезка прямой кишки, выведение анального отрезка сигмовидной кишки на кожу;**
- 5) экстирпация прямой кишки с зашиванием анального отверстия, с последующим выведением анального отрезка сигмовидной кишки на кожу.

9.166 (УНПО) При выполнении правосторонней гемиколэктомии по поводу рака хирург должен удалить:

- 1) слепую и восходящую ободочную кишку вместе с околокишечной клетчаткой;
- 2) 40 см от баугиневой заслонки подвздошную кишку, слепую и восходящую ободочную без околокишечной клетчатки;
- 3) 15 см от баугиниевой заслонки подвздошную кишку, слепую и восходящую ободочную с околокишечной клетчаткой;
- 4) 40 см от баугиниевой заслонки подвздошную кишку, слепую и восходящую ободочную с околокишечной клетчаткой;
- 5) подвздошную кишку на 15 см от баугиниевой заслонки, слепую и восходящую и половину поперечной ободочной кишки с околокишечной клетчаткой.**

9.167 (УНВПО) Венозный отток от поперечной ободочной кишки происходит в вену:

- 1) правую желудочно-сальниковую;
- 2) селезеночную;
- 3) левую желудочно-сальниковую;
- 4) верхнюю брыжеечную;**
- 5) нижнюю брыжеечную.**

9.168 (УНПО) Лимфоотток от поперечной ободочной кишки осуществляется во все лимфатические узлы, кроме:

- 1) внутренних подвздошных;
- 2) нижних паракавальных;

- 3) парааортальных;
- 4) верхних брыжеечных;
- 5) верхних прямокишечных.**

9.169 (УНПО) К нисходящей ободочной кишке прилежат все образования брюшной полости, за исключением:

- 1) париетального листка брюшины;
- 2) мышц задней брюшной стенки;
- 3) наружного края левой почки;
- 4) боковой стенки живота;
- 5) корня брыжейки тонкой кишки.**

9.170 (УНПО) Кровоснабжение нисходящей ободочной кишки осуществляется за счет артерии:

- 1) левой ободочной;**
- 2) левой почечной;
- 3) левой яичковой (яичниковой);
- 4) левой желудочно-сальниковой;
- 5) селезеночной.

9.171 (УНПО) Венозный отток от поперечной ободочной кишки происходит в систему вены:

- 1) верхней брыжеечной;
- 2) нижней и верхней брыжеечной;**
- 3) селезеночной;
- 4) левой почечной;
- 5) ни один из вариантов.

9.172 (УНПО) Венозный отток от нисходящего отдела ободочной кишки осуществляется в систему:

- 1) нижней поллой вены;
- 2) верхней поллой вены;
- 3) нижней поллой и воротной вен;
- 4) воротной вены;**
- 5) воротной и верхней поллой вен.

9.173 (УНПО) К сигмовидной кишке прилежат все образования брюшной полости, за исключением:

- 1) корня брыжейки тонкой кишки;**
- 2) общих подвздошных артерий и вены;
- 3) поясничной мышцы;
- 4) заднего париетального листка брюшины;
- 5) передней брюшной стенки.**

9.174 (УНПО) К сигмовидной кишке спереди прилежит:

- 1) передняя брюшная стенка;
- 2) петли тонкой кишки;**
- 3) большой сальник;
- 4) корень брыжейки тонкой кишки;
- 5) ни один из вариантов.

9.175 (УНПО) К ободочной кишке в области правой печеночной кривизны прилежат все образования, кроме:

- 1) правой доли печени;
- 2) дна желчного пузыря;

- 3) нижнего горизонтального отдела 12-перстной кишки;
- 4) нисходящего отдела 12-перстной кишки;
- 5) желчного протока.**

9.176 (УНПО) Кровоснабжение печеночной кривизны ободочной кишки осуществляет артерия:

- 1) правая почечная;
- 2) общая печеночная;
- 3) нижняя брыжеечная;
- 4) верхняя брыжеечная;**
- 5) правая желудочно-сальниковая.

9.177 (УНПО) К поперечной ободочной кишке в брюшной полости прилежат все образования, за исключением:

- 1) печени;
- 2) желчного пузыря;
- 3) большой кривизны желудка;
- 4) селезенки;
- 5) ни один из вариантов.**

9.178 (УНПО) К поперечной ободочной кишке в брюшной полости прилежат все образования, за исключением:

- 1) петель тонкой кишки;
- 2) большого сальника;
- 3) передней брюшной стенки;
- 4) 12-перстной кишки;
- 5) ни один из вариантов.**

9.179 (УНВПО) К брыжейке поперечной ободочной кишки прилежит:

- 1) головка поджелудочной железы;
- 2) правая почка;
- 3) ворота левой почки;**
- 4) воротная вена;
- 5) нисходящий отдел 12-перстной кишки.**

9.180 (УНВПО) Поперечная ободочная кишка кровоснабжается из бассейна:

- 1) верхней брыжеечной артерии;**
- 2) нижней брыжеечной артерии;**
- 3) общей печеночной артерии;
- 4) правой желудочной артерии;
- 5) правой желудочно-сальниковой артерии.

9.181 (УНПО) Поперечную ободочную кишку кровоснабжает артерия:

- 1) подвздошно-ободочная;
- 2) правая ободочная;
- 3) левая ободочная;
- 4) правая желудочно-сальниковая;
- 5) средняя ободочная.**

9.182 (УНПО) Венозный отток от поперечной ободочной кишки осуществляется в систему вены:

- 1) нижней полой;
- 2) воротной;**
- 3) верхней полой;

- 4) воротной и нижней полой;
- 5) воротной и верхней полой.

9.183 (УНВПО) К асептическим кишечным швам относятся все швы, кроме:

- 1) шва Жели;
- 2) шва Пирогова;
- 3) шва Ламбера;
- 4) шва Бира;
- 5) шва Шмидена.

9.184 (УНПО) При ушивании прободной язвы желудка в первый ряд швов захватывают:

- 1) слизисто-подслизистые слои;
- 2) серозно-мышечно-подслизистые слои поперечно к оси желудка;
- 3) серозно-мышечные слои продольно к оси желудка;
- 4) серозно-мышечные слои поперечно к оси желудка;
- 5) все слои поперечно к оси желудка.

9.185 (УНВПО) При ушивании прободной язвы желудка вторым рядом швов захватывают:

- 1) все слои;
- 2) все слои с подведением сальника на ножке;
- 3) серозно-мышечные слои с подведением сальника на ножке;
- 4) серозно-мышечные слои;
- 5) серозно-мышечные слои с подведением свободного лоскута сальника.

9.186 (УНПО) При выполнении гастротомии следующим действием хирурга после выполнения послойной верхней срединной лапаротомии:

- 1) проведение гемостаза;
- 2) вскрытия стенки желудка продольно;
- 3) выполнения ревизии отделов вскрытого желудка;
- 4) зашивания раны желудка послойно;
- 5) зашивания раны брюшной полости послойно.

9.187 (УНПО) При выполнении гастростомии по Витцелю действия хирурга правильны, за исключением:

- 1) наложения трубки на желудок по его оси на середине между малой и большой кривизной;
- 2) фиксации трубки к стенке желудка 6-8 шелковыми серозномышечными швами;
- 3) наложения кисетного шва у верхнего края фиксирующих трубку швов, рассечения в кисете стенки желудка, введения трубки;
- 4) затягивания кисета и перитонизации его дополнительно 2-3 серозно-мышечными швами;
- 5) выведения трубки на кожу через верхний срединный лапаротомный разрез.

9.188 (УНПО) При выполнении гастростомии по Штамму-Каделу все действия хирурга правильны, за исключением:

- 1) послойного вскрытия брюшной полости верхней срединной лапаротомией;
- 2) наложения двух лигатур-держалок на стенку желудка;
- 3) наложения трех концентрических кисетных швов на стенку желудка, вскрытия в центре просвета и введения трубки;
- 4) последовательного затягивания кисетных швов с погружением трубки в желудок;
- 5) выведения трубки наружу и фиксации стенки желудка к брюшине.

9.189 (УНПО) При наложении межкишечного анастомоза по Пирогову-Черни во второй ряд швов захватывают слои кишки:

- 1) слизистые;
- 2) слизисто-подслизистые;
- 3) серозно-мышечные;**
- 4) серозно-мышечно-подслизистые;
- 5) все слои.

9.190 (УНПО) При наложении двухрядного межкишечного анастомоза используют последовательно отдельные кишечные швы:

- 1) Ламбера→Ламбера→Жели→Ламбера;
- 2) Жели→Шмидена→Жели→Жели;
- 3) Ламбера→Жели→Шмидена→Ламбера;**
- 4) Ламбера→Шмидена→Жели→Ламбера;
- 5) ни один из вариантов.

9.191 (УНПО) При наложении трехрядного межкишечного анастомоза используют последовательно отдельные швы по автору:

- 1) Ламбер→Жели→Шмиден→Ламбер→Ламбер→Ламбер;**
- 2) Жели→Шмиден→Ламбер→Ламбер→Жели→Жели;
- 3) Ламбер→Шмиден→Ламбер→Жели→Ламбер→Ламбер;
- 4) Жели→Жели→Жели→Жели→Ламбер→Ламбер;
- 5) Жели→Шмиден→Ламбер→Ламбер→Ламбер→Ламбер.

9.192 (УНПО) При наложении межкишечного анастомоза по Вельфлеру в первый ряд швов захватывают слои кишки:

- 1) слизистые;**
- 2) слизисто-подслизистые;
- 3) серозно-мышечные;
- 4) подслизистые;
- 5) все слои.

9.193 (УНПО) При наложении межкишечного анастомоза по Вельфлеру во второй ряд швов захватывают слои:

- 1) слизистые;
- 2) слизисто-подслизистые;
- 3) серозно-мышечные;**
- 4) серозно-мышечно-подслизистые;
- 5) ни один из вариантов.

9.194 (УНПО) При наложении межкишечного анастомоза по Корабельникову-Матешуку в шов захватывают слои:

- 1) серозно-мышечные;
- 2) серозно-мышечно-подслизистые;**
- 3) слизисто-подслизистые;
- 4) все слои;
- 5) серозные.

9.195 (УНПО) При наложении межкишечного анастомоза по Кирпатовскому в первый ряд швов захватывают слои кишки:

- 1) слизистые;
- 2) подслизистые;**
- 3) серозно-мышечные;
- 4) все слои;
- 5) серозно-мышечно-подслизистые.

9.196 (УНПО) При наложении межкишечного анастомоза по Кирпатовскому во второй ряд швов захватывают слои кишки:

- 1) все слои;
- 2) серозные;
- 3) серозно-мышечные;**
- 4) серозно-мышечно-подслизистые;
- 5) подслизистые.

9.197 (УНПО) К инфицированным кишечным швам относятся все, кроме:

- 1) шва Шмидена;
- 2) шва Ламбера;**
- 3) шва Жели;
- 4) шва Пирогова;**
- 5) шва Бира.**

9.198 (УНПО) К слепой кишке прилежат все образования, за исключением:

- 1) правого мочеточника;
- 2) нижней полой вены;**
- 3) забрюшинной клетчатки;
- 4) боковой брюшной стенки;
- 5) ни один из вариантов.

9.199 (УНПО) Кровоснабжение слепой кишки осуществляется из бассейна артерии:

- 1) верхней брыжеечной;**
- 2) нижней брыжеечной;
- 3) наружной подвздошной;
- 4) внутренней подвздошной;
- 5) общей печеночной.

9.200 (УНПО) Венозный отток от слепой кишки осуществляется в систему вены:

- 1) нижней полой;
- 2) верхней полой;
- 3) нижней и верхней полых;
- 4) воротной;**
- 5) воротной и нижней полой.

9.201 (УНПО) Иннервацию слепой кишки осуществляет:

- 1) половое-бедренный нерв;
- 2) верхнее подчревное сплетение;
- 3) нижнее подчревное сплетение;
- 4) нижнее брыжеечное сплетение;
- 5) верхнее брыжеечное сплетение.**

9.202 (УНПО) Лимфоотток от слепой кишки направлен в:

- 1) нижние брыжеечные лимфатические узлы;
- 2) околоаортальные лимфатические узлы;
- 3) верхние брыжеечные лимфатические узлы;**
- 4) внутренние подвздошные лимфатические узлы;
- 5) глубокие паховые лимфатические узлы.

9.203 (УНПО) К восходящей части ободочной кишки прилежат все образования, кроме:

- 1) петель тонкой кишки;
- 2) большого сальника;

- 3) боковой стенки живота;
- 4) околотолстокишечной забрюшинной клетчатки;
- 5) ни один из вариантов.**

9.204 (УНПО) К восходящей части ободочной кишки прилежат:

- 1) корень брыжейки тонкой кишки;
- 2) желудочно-ободочная связка;
- 3) нижний полюс правой почки;**
- 4) 12-перстно-тощая кривизна;
- 5) ворота правой почки.

9.205 (УНПО) При осуществлении доступа к среднему отделу правого мочеточника в брюшной полости используют ориентир:

- 1) корень брыжейки тонкой кишки;
- 2) верхний подвздошно-слепокишечный карман;**
- 3) нижний подвздошно-слепокишечный карман;
- 4) медиальный край восходящей ободочной кишки;
- 5) латеральный край восходящей ободочной кишки.

9.206 (УНПО) По отношению к позвоночнику начальный отдел корня брыжейки тощей кишки находится на уровне позвонка:

- 1) XI грудного;
- 2) XII грудного;
- 3) I поясничного;
- 4) II поясничного;**
- 5) III поясничного.

9.207 (УНПО) По отношению к позвоночнику конечный отдел корня брыжейки подвздошной кишки находится на уровне:

- 1) III поясничного позвонка;
- 2) IV поясничного позвонка;
- 3) V поясничного позвонка;
- 4) правого крестцово-подвздошного сочленения;**
- 5) большой седалищной вырезки тазовой кости.

9.208 (УНПО) Кровоснабжение тощего отдела тонкой кишки осуществляется за счет ветвей артерий:

- 1) нижней брыжеечной;
- 2) верхней брыжеечной;**
- 3) селезеночной;
- 4) общей печеночной;
- 5) левой и правой желудочно-сальниковых.

9.209 (УНПО) Кровоснабжение подвздошного отдела тонкой кишки, осуществляется за счет ветвей артерии:

- 1) нижней брыжеечной;
- 2) верхней брыжеечной;**
- 3) селезеночной;
- 4) общей печеночной;
- 5) левой и правой желудочно-сальниковых.

9.210 (УНПО) Венозный отток от тощего отдела тонкой кишки осуществляется в систему вены:

- 1) нижней поллой;

- 2) верхней полостью;
- 3) воротной;**
- 4) воротной и нижней полостью;
- 5) воротной и верхней полостью.

9.211 (УНПО) Венозный отток от подвздошного отдела тонкой кишки осуществляется в систему вен:

- 1) нижней полостью;
- 2) верхней полостью;
- 3) воротной;**
- 4) воротной и нижней полостью;
- 5) воротной и верхней полостью.

9.212 (УНПО) Толстую кишку отличают от тонкой по всем признакам, кроме:

- 1) наличия продольных мышечных лент;
- 2) наличия вздутий и циркулярных борозд;
- 3) диаметра кишки;**
- 4) наличия жировых подвесок;
- 5) серо-голубого цвета.

9.213 (УНПО) К слепой кишке в полости большого таза прилежат все образования, кроме:

- 1) петель подвздошной кишки;
- 2) подвздошно-поясничной мышцы;
- 3) передней брюшной стенки;
- 4) забрюшинной клетчатки;
- 5) ни один из вариантов.**

9.214 (УНПО) К большой кривизне желудка прилежат:

- 1) селезенка;
- 2) поперечная ободочная кишка;**
- 3) нисходящая ободочная кишка;
- 4) диафрагма;**
- 5) боковая брюшная стенка.

9.215 (УНПО) Переднюю стенку сальниковой сумки составляет связка желудка:

- 1) желудочно-печеночная;**
- 2) желудочно-селезеночная;
- 3) желудочно-ободочная;
- 4) желудочно-поджелудочная;
- 5) желудочно-пищеводная.

9.216 (УНПО) Селезеночная артерия проходит между листками связки желудка:

- 1) желудочно-селезеночная;**
- 2) желудочно-поджелудочная;
- 3) желудочно-диафрагмальная;
- 4) желудочно-ободочная;
- 5) ни один из вариантов.

9.217 (УНПО) Правую желудочно-сальниковую артерию содержит связка желудка:

- 1) желудочно-селезеночная;
- 2) желудочно-печеночная;
- 3) желудочно-поджелудочная;
- 4) желудочно-12-перстная;
- 5) желудочно-ободочная.**

9.218 (УНПО) Левую желудочную артерию содержит связка желудка:

- 1) желудочно-печеночная;
- 2) желудочно-пищеводная;
- 3) желудочно-селезеночная;
- 4) желудочно-поджелудочная;**
- 5) желудочно-ободочная.

9.219 (УНПО) Левый ствол блуждающего нерва содержит связка желудка:

- 1) желудочно-ободочная;
- 2) желудочно-печеночная;
- 3) желудочно-пищеводная;**
- 4) желудочно-поджелудочная;
- 5) ни один из вариантов.

9.220 (УНПО) Начало селезеночной артерии содержит связка желудка:

- 1) желудочно-поджелудочная;
- 2) желудочно-селезеночная;**
- 3) желудочно-диафрагмальная;
- 4) желудочно-печеночная;
- 5) желудочно-пищеводная.

9.221 (УНПО) Правая желудочная артерия берет начало от:

- 1) чревного ствола;
- 2) левой желудочной артерии;
- 3) общей печеночной артерии;**
- 4) собственной печеночной артерии;
- 5) селезеночной артерии.

9.222 (УНПО) Левая желудочная артерия берет начало от:

- 1) общей печеночной артерии;
- 2) чревного ствола;**
- 3) верхней брыжеечной артерии;
- 4) селезеночной артерии;
- 5) левой желудочно-сальниковой артерии.

9.223 (УНПО) К нижней стенке желудка прилежит:

- 1) поперечная ободочная кишка;
- 2) поджелудочная железа;
- 3) желудочно-ободочная связка;
- 4) брыжейка поперечной ободочной кишки;**
- 5) ни один из вариантов.

9.224 (УНПО) К задней поверхности селезенки прилежат все образования, кроме:

- 1) поясничной части диафрагмы;
- 2) хвоста поджелудочной железы;**
- 3) селезеночной кривизны ободочной кишки;**
- 4) левой почки;
- 5) левого надпочечника.

9.225 (УНПО) К нижней поверхности селезенки прилежат все образования, кроме:

- 1) левой почки;**

- 2) хвоста поджелудочной железы;
- 3) левого надпочечника;**
- 4) селезеночной кривизны ободочной кишки;
- 5) ободочно-диафрагмальной связки.

9.226 (УНВПО) К задней стенке желудка прилежат все образования, кроме:

- 1) левой доли печени;**
- 2) париетального листка брюшины;
- 3) поджелудочной железы;
- 4) брыжейки поперечно-ободочной кишки;**
- 5) брюшной аорты.

9.227 (УНПО) К желудку сверху прилежит:

- 1) левая доля печени;
- 2) диафрагма;**
- 3) селезенка;
- 4) левое легкое;
- 5) ни один из вариантов.

9.228 (УНВПО) К желудку спереди прилежат:

- 1) левая доля печени;**
- 2) поперечная ободочная кишка;
- 3) правая доля печени;
- 4) передняя брюшная стенка;**
- 5) тонкая кишка.

9.229 (УНПО) Большая кривизна желудка лежит на уровне:

- 1) XII грудного позвонка;
- 2) I поясничного позвонка
- 3) II поясничного позвонка;**
- 4) III поясничного позвонка;
- 5) IV поясничного позвонка.

9.230 (УНВПО) Скелетотопия кардиального отдела желудка соответствует:

- 1) точке пересечения IV ребра с грудиной;
- 2) точке пересечения VI ребра с мечевидным отростком;**
- 3) точке пересечения VII ребра с мечевидным отростком;**
- 4) вершине мечевидного отростка;
- 5) середине бикостарной линии.

9.231 (УНПО) Заднюю стенку полости сальниковой сумки составляют все образования, кроме:

- 1) брюшной аорты;
- 2) нижней полой вены;
- 3) поясничной части диафрагмы;
- 4) задней стенки желудка;**
- 5) поджелудочной железы.

9.232 (УНВПО) При формировании культи 12-перстной кишки её просвет закрывают швом:

- 1) Шмидена;
- 2) Ламбера;
- 3) Жели;
- 4) Шмидена и Ламбера;**

5) Жели и Ламбера.

9.233 (УНПО) Верхней границей левой брыжеечной пазухи является:

- 1) поперечная ободочная кишка и её брыжейка;**
- 2) большая кривизна желудка;
- 3) поджелудочная железа;
- 4) корень брыжейки тонкой кишки;
- 5) ни один из вариантов.

9.234 (УНПО) Верхней границей правой брыжеечной пазухи является:

- 1) пилорический отдел желудка;
- 2) луковичный отдел 12-перстной кишки;
- 3) верхняя горизонтальная часть 12-перстной кишки;
- 4) поперечная ободочная кишка и её брыжейка;**
- 5) поджелудочная железа.

9.235 (УНВПО) Сообщения правой и левой брыжеечных пазух имеются:

- 1) между петлями тонкой кишки и передней брюшной стенкой;**
- 2) через отверстие в корне брыжейки тонкой кишки;
- 3) через отверстия в брыжейке поперечной ободочной кишки;
- 4) между началом корня брыжейки тонкой кишки и брыжейкой поперечной ободочной кишки;**
- 5) не сообщаются.

9.236 (УНВПО) Вдоль медиального края восходящей ободочной кишки забрюшинно проецируется:

- 1) ветви верхней брыжеечной артерии;**
- 2) лоханка правой почки;
- 3) нижняя полая вена;
- 4) брюшная аорта;
- 5) правый мочеточник.**

9.237 (УНВПО) Вдоль медиального края нисходящей ободочной кишки забрюшинно проецируется:

- 1) лоханка левой почки;
- 2) брюшная аорта;
- 3) нижняя полая вена;
- 4) ветви нижней брыжеечной артерии;**
- 5) левый мочеточник.**

9.238 (УНПО) Заднюю стенку правой печеночной сумки составляет:

- 1) диафрагма,
- 2) венечная связка печени;**
- 3) задне-нижняя поверхность печени;
- 4) верхний полюс правой почки;
- 5) ни один из вариантов.

9.239 (УНПО) Сзади в области спины верхняя граница печени соответствует позвонку:

- 1) VII грудному;
- 2) IX грудному;
- 3) X грудному;**
- 4) XII грудному;
- 5) I поясничному.

9.240 (УНПО) Сзади в области спины нижняя граница печени соответствует позвонку:

- 1) X грудному;
- 2) XII грудному;
- 3) I поясничному;**
- 4) III поясничному;
- 5) ни один из вариантов.

9.241 (УНПО) По отношению к ребрам грудной клетки печень справа располагается:

- 1) от III до X ребра;
- 2) от IV до X ребра;**
- 3) от V до X ребра;
- 4) от VI до XI ребра;
- 5) от VII до XI ребра.

9.242 (УНПО) По отношению к ребрам грудной клетки печень слева располагается:

- 1) от IV до VII ребра;
- 2) от IV до VIII ребра;
- 3) от V до VII ребра;**
- 4) от V до IX ребра;
- 5) от VI до X ребра.

9.243 (УНВПО) К передней поверхности печени прилежат все образования, кроме:

- 1) диафрагмы;
- 2) передней брюшной стенки;
- 3) передней грудной стенки;
- 4) поперечной ободочной кишки;**
- 5) большого сальника.**

9.244 (УНПО) К задней поверхности печени прилежат все образования, кроме:

- 1) X-XI грудных позвонков;
- 2) ножек диафрагмы;
- 3) брюшного отдела пищевода;
- 4) нижней полой вены;
- 5) ни один из вариантов.**

9.245 (УНВПО) К задней поверхности печени прилежат:

- 1) желчный пузырь;
- 2) 12-перстная кишка;
- 3) малая кривизна желудка;
- 4) аорта;**
- 5) правый надпочечник.**

9.246 (УНПО) К нижней поверхности печени прилежат все образования, кроме:

- 1) желудка;
- 2) горизонтальной части 12-перстной кишки;
- 3) печеночной кривизны поперечной ободочной кишки;
- 4) большого сальника;**
- 5) верхнего полюса правой почки.

9.247 (УНПО) Брюшина покрывает печень со всех сторон, кроме ее поверхности:

- 1) верхней;
- 2) нижней;
- 3) передней;
- 4) задней;**
- 5) ни один из вариантов.

9.248 (УНПО) Основными источниками кровоснабжения печени являются:

- 1) общая печёночная артерия;
- 2) воротная вена;
- 3) собственная печёночная артерия и воротная вена;**
- 4) междрёберные артерии;
- 5) диафрагмальные артерии.

9.249 (УНПО) Заднюю стенку правого бокового канала брюшной полости составляет:

- 1) восходящая ободочная кишка;
- 2) боковая поверхность брюшной стенки;
- 3) задний листок париетальной брюшины;**
- 4) корень брыжейки тонкой кишки;
- 5) ни один из вариантов.

9.250 (УНПО) Медиальную стенку правого бокового канала брюшной полости составляет:

- 1) восходящая ободочная кишка;**
- 2) корень брыжейки тонкой кишки;
- 3) передняя брюшная стенка;
- 4) серповидная связка печени;
- 5) печёчно-почечная связка.

9.251 (УНПО) Правый боковой канал брюшной полости сообщается со всеми образованиями, кроме:

- 1) печёночной сумки;
- 2) подпечёчного пространства;
- 3) полости малого таза;
- 4) полости сальниковой сумки;
- 5) правого брыжеечного синуса.**

9.252 (УНПО) Левый боковой канал брюшной полости сообщается с:

- 1) печёночной сумкой;
- 2) подпечёчным пространством;
- 3) полостью малого таза;**
- 4) полостью сальниковой сумки;
- 5) левым брыжеечным синусом.

9.253 (УНПО) Верхнюю стенку левого бокового канала брюшной полости составляет:

- 1) селезенка;
- 2) поддерживающая связка селезенки;**
- 3) селезеночный угол толстой кишки;
- 4) большая кривизна желудка;
- 5) ни один из вариантов.

9.254 (УНПО) Верхнюю стенку правого бокового канала брюшной полости составляет:

- 1) нисходящий отдел 12-перстной кишки;
- 2) печеночный угол толстой кишки;
- 3) диафрагма;

- 4) **задне-нижняя поверхность печени;**
- 5) нижний горизонтальный отдел 12-перстной кишки.

9.255 (УНПО) Латеральную стенку левого бокового канала брюшной полости составляет:

- 1) нисходящая ободочная кишка;
- 2) корень брыжейки тонкой кишки;
- 3) **боковая стенка живота;**
- 4) брыжейка сигмовидной кишки;
- 5) сигмовидная кишка.

9.256 (УНПО) Латеральной границей правой брыжеечной пазухи является:

- 1) корень брыжейки сигмовидной кишки;
- 2) корень брыжейки тонкой кишки;
- 3) **медиальный край восходящей ободочной кишки;**
- 4) правая боковая стенка живота;
- 5) латеральный край восходящей ободочной кишки.

9.257 (УНПО) Брюшная полость условно делится на верхний и нижний этажи посредством:

- 1) поперечной ободочной кишки;
- 2) линии, проведенной через большую кривизну желудка;
- 3) **брыжейки поперечной ободочной кишки;**
- 4) верхнего края поджелудочной железы;
- 5) нижнего края поджелудочной железы.

9.258 (УНПО) Медиальную стенку правой печеночной сумки составляет:

- 1) левая доля печени;
- 2) венечная связка печени;
- 3) печеночно-желудочная связка;
- 4) печеночно-12-перстная связка;
- 5) **серповидная связка печени.**

9.259 (УНПО) Переднюю стенку правой печеночной сумки составляют:

- 1) печень;
- 2) диафрагма;
- 3) передняя брюшная стенка;
- 4) **диафрагма и передняя брюшная стенка;**
- 5) венечная связка печени.

9.260 (УНПО) Переднюю стенку сальниковой сумки составляет:

- 1) нижняя поверхность печени;
- 2) печеночно-желудочная связка;
- 3) печеночно-12-перстная связка;
- 4) **печеночно-желудочная связка и задняя стенка желудка;**
- 5) задняя стенка желудка.

9.261 (УНПО) Переднюю стенку преджелудочной сумки составляет:

- 1) брюшная стенка;
- 2) поперечная ободочная кишка;
- 3) брыжейка поперечной ободочной кишки;
- 4) задне-нижняя поверхность печени;
- 5) **брюшная стенка и задне-нижняя поверхность печени.**

9.262 (УНПО) Нижнюю стенку сальниковой сумки составляет:

- 1) поперечная ободочная кишка;
- 2) желудочно-ободочная связка;
- 3) брыжейка поперечной ободочной кишки;**
- 4) поджелудочная железа;
- 5) ни один из вариантов.

9.263 (УНПО) В полость сальниковой сумки можно проникнуть через все образования, кроме:

- 1) брыжейки поперечной ободочной кишки;
- 2) большого сальника;**
- 3) печеночно-желудочной связки;
- 4) желудочно-ободочной связки;
- 5) желудка.

9.264 (УНПО) Заднюю стенку сальникового отверстия составляет:

- 1) печеночно-12-перстная связка;
- 2) желудочно-12-перстная связка;
- 3) желудочно-поджелудочная связка;
- 4) задне-нижняя поверхность печени;
- 5) ни один из вариантов.**

9.265 (УНПО) Элементами печеночно – 12-перстной связки являются все образования, кроме:

- 1) воротной вены;
- 2) нижней полой вены;**
- 3) печеночной артерии;
- 4) общего желчного протока;
- 5) жировой клетчатки.

9.266 (УНПО) Собственная печеночная артерия по отношению к общему желчному протоку находится:

- 1) латерально;
- 2) сзади;
- 3) спереди;
- 4) медиально;**
- 5) латерально и спереди.

9.267 (УНПО) Воротная вена по отношению к нижней полой вене находится:

- 1) сзади и медиально;
- 2) сзади и латерально;
- 3) латерально;
- 4) спереди и медиально;
- 5) спереди и латерально.**

9.268 (УНПО) Общий желчный проток по отношению к воротной вене находится:

- 1) сзади и медиально;
- 2) сзади и латерально;
- 3) спереди и латерально;**
- 4) спереди и медиально;
- 5) медиально.

9.269 (УНПО) Переднюю стенку сальниковой сумки образуют все связки, кроме:

- 1) печеночно-12-перстной;

- 2) печеночно-желудочной;
- 3) печеночно-пищеводной;
- 4) желудочно-ободочной;
- 5) печеночно-почечной.**

9.270 (УНПО) Переднее печеночное нервное сплетение находится:

- 1) впереди желчного протока и печеночной артерии вне печеночно-12-перстной связки;
- 2) впереди желчного протока и печеночной артерии в печеночно-12-перстной связке;**
- 3) вдоль нижней полой вены;
- 4) вдоль воротной вены;
- 5) ни один из вариантов.

9.271 (УНПО) Заднее печеночное нервное сплетение находится:

- 1) впереди желчного протока и печеночной артерии вне печеночно-12-перстной связки;
- 2) впереди желчного протока и печеночной артерии в печеночно-12-перстной связке;
- 3) между желчным протоком и воротной веной;**
- 4) позади воротной вены вне печеночно-12-перстной связки;
- 5) ни один из вариантов.

9.272 (УНПО) Сзади со стороны спины желчный пузырь находится на уровне позвонка:

- 1) X грудного;
- 2) XI грудного;
- 3) XII грудного;
- 4) I поясничного;**
- 5) II поясничного.

9.273 (УНВПО) К желчному пузырю прилежат все образования, кроме:

- 1) печени;
- 2) привратниковой части желудка;
- 3) печеночного изгиба поперечной ободочной кишки;
- 4) головки поджелудочной железы;**
- 5) восходящего отдела 12-перстной кишки.**

9.274 (УНПО) К желчному пузырю в области дна прилежит:

- 1) печень;
- 2) поперечная ободочная кишка;
- 3) малая кривизна желудка;
- 4) большая кривизна желудка;
- 5) передняя брюшная стенка.**

9.275 (УНПО) К шейке желчного пузыря прилежит:

- 1) малая кривизна желудка;
- 2) луковица 12-перстной кишки;**
- 3) поперечная ободочная кишка;
- 4) нисходящий отдел 12-перстной кишки;
- 5) головка поджелудочной железы.

9.276 (УНВПО) Треугольник Калло в толще печеночно-двенадцатиперстной связки составляют все образования, кроме:

- 1) пузырной артерии;**
- 2) общего печеночного протока;
- 3) пузырного протока;

- 4) правой печеночной артерии;
- 5) левой печеночной артерии.**

9.277 (УНПО) Содержимым треугольника Калло в толще печеночно – двенадцатиперстной связки является:

- 1) правая печеночная артерия;
- 2) пузырный проток;
- 3) пузырная артерия;**
- 4) собственная печеночная артерия;
- 5) ни один из вариантов.

9.278 (УНПО) Знание составляющих сторон треугольника Калло необходимо при выполнении:

- 1) холецистостомии;
- 2) холецистоюноанастомоза;
- 3) холецистодуоденоанастомоза;
- 4) холецистэктомии;**
- 5) резекции печени.

9.279 (УНПО) По отношению к позвоночному столбу селезенка находится на уровне позвонков:

- 1) X грудного - II поясничного;**
- 2) VIII-X грудных;
- 3) VI-VIII грудных;
- 4) II-IV поясничных;
- 5) ни один из вариантов.

9.280 (УНПО) К селезенке спереди и медиально прилежит:

- 1) реберная часть диафрагмы;
- 2) поперечная ободочная кишка;
- 3) нисходящая ободочная кишка;
- 4) дно и большая кривизна желудка;**
- 5) левая доля печени.

9.281 (УНПО) Нисходящая часть двенадцатиперстной кишки прилежит ко всем образованиям, кроме:

- 1) нижней полой вены;
- 2) головки поджелудочной железы;
- 3) печеночной кривизны ободочной кишки;
- 4) правой почки;
- 5) ни один из вариантов.**

9.282 (УНВПО) К нисходящей части двенадцатиперстной кишки прилежат:

- 1) брюшная аорта;
- 2) лоханочно-мочеточниковый сегмент;**
- 3) ствол верхней брыжеечной артерии;
- 4) нижняя полая вена;**
- 5) большая кривизна желудка.

9.283 (УНВПО) К горизонтальной части двенадцатиперстной кишки не прилежат:

- 1) восходящая ободочная кишка;**
- 2) головка поджелудочной железы;
- 3) нижний полюс правой почки;
- 4) верхние брыжеечные артерия и вены;

5) большая кривизна желудка.

9.284 (УНВПО) К горизонтальной части двенадцатиперстной кишки прилежат:

- 1) тонкая кишка;
- 2) головка поджелудочной железы;
- 3) брюшная аорта;
- 4) воротная вена;
- 5) желудочно-ободочная связка.

9.285 (УНПО) К нисходящей части двенадцатиперстной кишки прилежит:

- 1) тощая кишка;
- 2) головка поджелудочной железы;
- 3) тело поджелудочной железы;
- 4) верхние брыжеечные артерия и вена;
- 5) подвздошная кишка.

9.286 (УНПО) К верхней части двенадцатиперстной кишки прилежит:

- 1) верхний полюс правой почки;
- 2) тонкая кишка;
- 3) правая доля печени;
- 4) большой сальник;
- 5) желудочно-ободочная связка.

9.287 (УНПО) К передней стенке горизонтальной части двенадцатиперстной кишки прилежат сосуды:

- 1) воротная вена;
- 2) верхние брыжеечные артерия и вена;
- 3) нижняя полая вена;
- 4) нижние брыжеечные артерия и вена;
- 5) брюшная аорта.

9.288 (УНПО) Двенадцатиперстную кишку кровоснабжают все артерии, кроме:

- 1) правой желудочной артерии;
- 2) правой желудочно-сальниковой артерии;
- 3) верхней поджелудочно-12-перстной артерии;
- 4) нижней поджелудочно-12-перстной артерии;
- 5) правой почечной артерии.

9.289 (УНПО) Левая желудочно-сальниковая артерия берет начало от:

- 1) левой желудочной артерии;
- 2) чревного ствола;
- 3) правой желудочной артерии;
- 4) селезеночной артерии;
- 5) верхней брыжеечной артерии.

9.290 (УНПО) Правая желудочно-сальниковая артерия берет начало от:

- 1) собственной печеночной артерии;
- 2) общей печеночной артерии;
- 3) 12-перстно-поджелудочной артерии;
- 4) верхней брыжеечной артерии;
- 5) ни один из вариантов.

9.291 (УНПО) В систему верхней полой вены отток венозной крови от желудка осуществляется через вены:

- 1) селезеночную;
- 2) правую желудочно-сальниковую;
- 3) левую желудочно-сальниковую;
- 4) левую венечную;
- 5) желудочно-пищеводные.**

9.292 (УНПО) В систему воротной вены отток венозной крови от желудка осуществляется через все вены, кроме:

- 1) селезеночной;
- 2) правой желудочно-сальниковой;
- 3) левой желудочно-сальниковой;
- 4) левой венечной;
- 5) ни один из вариантов.**

9.293 (УНПО) Лимфоотток от желудка осуществляется во все группы лимфатических узлов, кроме:

- 1) большого сальника;
- 2) малого сальника;
- 3) чревного ствола, аорты;
- 4) нижней полой вены;
- 5) ни один из вариантов.**

9.294 (УНПО) По отношению к позвоночнику верхняя часть 12-перстной кишки находится на уровне позвонка:

- 1) XII грудного;**
- 2) I поясничного;
- 3) II поясничного;
- 4) III поясничного;
- 5) X грудного.

9.295 (УНПО) По отношению к позвоночнику горизонтальная часть 12-перстной кишки находится на уровне позвонка:

- 1) XII грудного;
- 2) I поясничного;
- 3) II поясничного;
- 4) III поясничного;**
- 5) X грудного.

9.296 (УНПО) Верхняя часть 12-перстной кишки прилежит ко всем образованиям, кроме:

- 1) желчного пузыря;
- 2) желчного протока;
- 3) печени;
- 4) корня брыжейки поперечной ободочной кишки;**
- 5) головки поджелудочной железы.

9.297 (УНПО) Иннервацию 12-перстной кишки осуществляют все нервные образования, кроме:

- 1) верхнего брыжеечного сплетения;
- 2) нижнего брыжеечного сплетения;**
- 3) переднего печеночного сплетения;
- 4) заднего печеночного сплетения;
- 5) правого почечного сплетения.

9.298 (УНПО) Лимфоотток от 12-перстной кишки происходит во все ближайшие коллекторы, кроме лимфатических узлов:

- 1) воротной вены,
- 2) нижней полой вены;
- 3) аорты;
- 4) нижней брыжеечной вены;**
- 5) верхней брыжеечной вены.

9.299 (УНПО) По отношению к позвоночнику поджелудочная железа находится на уровне позвонков:

- 1) IX-XI грудных;
- 2) X-XI грудных;
- 3) XII грудного - II поясничного;**
- 4) II-III поясничных;
- 5) III-IV поясничных.

9.300 (УНВПО) К поджелудочной железе спереди прилежат все образования, кроме:

- 1) желудка;
- 2) желудочно-ободочной связки;**
- 3) корня брыжейки поперечной ободочной кишки;
- 4) тощей кишки,**
- 5) селезеночного изгиба ободочной кишки.

9.301 (УНПО) К поджелудочной железе сзади прилежат все образования, кроме:

- 1) начала воротной вены;
- 2) верхних брыжеечных вены и артерии;
- 3) нижней полой вены и аорты;
- 4) левой почки;
- 5) ни один из вариантов.**

9.302 (УНВПО) К поджелудочной железе сзади прилежат:

- 1) верхний полюс правой почки;
- 2) правый надпочечник;
- 3) 12-перстная кишка;
- 4) начало воротной вены;**
- 5) верхние брыжеечные вена и артерия.**

9.303 (УНПО) К поджелудочной железе сзади прилежит:

- 1) левый надпочечник;
- 2) 12-перстная кишка;
- 3) хвостатая доля печени;
- 4) нижняя полая вена и аорта;**
- 5) корень брыжейки поперечной ободочной кишки.

9.304 (УНПО) К поджелудочной железе сзади прилежат:

- 1) левая почка;**
- 2) хвостатая доля печени;
- 3) 12-перстная кишка;
- 4) тощая кишка;
- 5) поперечная ободочная кишка.

9.305 (УНВПО) К поджелудочной железе снизу прилежат:

- 1) 12-перстная кишка;**
- 2) 12-перстно-тощий изгиб;**

- 3) **верхние брыжеечные вена и артерия;**
- 4) корень брыжейки поперечной ободочной кишки;
- 5) ни один из вариантов.

9.306 (УНПО) К головке поджелудочной железы латерально прилежит:

- 1) пилорический отдел желудка;
- 2) ворота правой почки;
- 3) **нисходящий отдел 12-перстной кишки;**
- 4) восходящая ободочная кишка;
- 5) ни один из вариантов.

9.307 (УНПО) К хвостовой части поджелудочной железы прилежит латерально:

- 1) поясничная часть диафрагмы;
- 2) **ворота селезенки;**
- 3) левая почка;
- 4) аорта;
- 5) селезеночный угол ободочной кишки.

9.308 (УНПО) Поджелудочную железу кровоснабжают все артерии, кроме:

- 1) селезеночной;
- 2) поджелудочно-12-перстной верхней;
- 3) поджелудочно-12-перстной нижней;
- 4) **нижней брыжеечной;**
- 5) **левой ободочной.**

9.309 (УНПО) Следующим действием хирурга при выполнении классической неосложненной аппендэктомии после оперативного доступа по Волковичу-Дьяконову будет:

- 1) **выведения отростка в рану;**
- 2) отсечения брыжейки от отростка;
- 3) гемостаза в ране;
- 4) наложения кисетного шва на купол слепой кишки вокруг основания отростка;
- 5) наложения лигатуры на основание отростка и его отсечение, погружение культи в кисет.

9.310 (УНПО) При выполнении гастроэнтероанастомоза по Вельфлеру следующим действием хирурга после вскрытия просвета желудка и кишки будет:

- 1) выполнение верхней срединной лапаротомии;
- 2) подведение петли кишки 20-40 см от связки Трейца к задней стенке желудка после рассечения брыжейки поперечной ободочной кишки;
- 3) подшивание кишки изоперистальтически по оси желудка серозно-мышечными швами;
- 4) **наложение соустья с помощью двухрядного кишечного шва;**
- 5) закрытие отверстия в желудочно-ободочной связке.

9.311 (УНПО) Венозный отток от поджелудочной железы осуществляется в систему вен:

- 1) нижней поллой;
- 2) верхней поллой;
- 3) **воротной;**
- 4) воротной и нижней поллой;
- 5) воротной и верхней поллой.

9.312 (УНПО) Иннервацию поджелудочной железы осуществляют все нервные сплетения, кроме:

- 1) солнечного;
- 2) печеночного;

- 3) селезеночного;
- 4) верхнего брыжеечного;
- 5) ни один из вариантов.**

9.313 (УНВПО) К отделам тощей и подвздошной кишки спереди прилежат:

- 1) большой сальник;**
- 2) поперечная ободочная кишка;**
- 3) восходящая ободочная кишка;
- 4) передняя брюшная стенка;**
- 5) сигмовидная кишка.

9.314 (УНПО) К задним отделам тощей и подвздошной кишки прилежат все образования, кроме:

- 1) почек;
- 2) нижней полой вены;
- 3) брюшной аорты с ветвями;
- 4) средних отделов мочеточников;
- 5) брыжейки поперечной ободочной кишки.**

9.315 (УНПО) Двухрядный кишечный шов можно накладывать на все отделы желудочно-кишечного тракта, кроме:

- 1) пищевода;
- 2) желудка;
- 3) 12-перстной кишки;
- 4) подвздошной кишки;
- 5) слепой кишки.**

9.316 (УНПО) Двухрядный кишечный шов можно накладывать на все отделы кишки, кроме:

- 1) слепой;
- 2) восходящей ободочной;
- 3) поперечной ободочной;
- 4) нисходящей ободочной;
- 5) ни один из вариантов.**

9.317 (УНВПО) Трехрядный кишечный шов необходимо накладывать на все отделы кишки, кроме:

- 1) тощей;**
- 2) подвздошной;**
- 3) слепой;
- 4) поперечной ободочной;
- 5) сигмовидной.

9.318 (УНВПО) Трехрядный кишечный шов на толстую кишку обусловлен всеми причинами, кроме:

- 1) высокой массивности микрофлоры;
- 2) высокой вирулентности микрофлоры;
- 3) тонкости стенки;
- 4) большого диаметра;**
- 5) низкой подвижности.**

9.319 (УНПО) При наложении межкишечного анастомоза по Альберту в первый ряд швов захватывают:

- 1) слизистые слои;

- 2) слизисто-подслизистые слои;
- 3) серозно-мышечные слои;
- 4) серозно-мышечно-подслизистые слои;
- 5) все слои.**

9.320 (УНПО) При наложении межкишечного анастомоза по Альберту во второй ряд швов захватывают:

- 1) слизистые слои;
- 2) слизисто-подслизистые слои;
- 3) серозно-мышечные слои;**
- 4) серозно-мышечно-подслизистые слои;
- 5) все слои.

9.321 (УНПО) При наложении межкишечного анастомоза по Альберту последовательно используют шовные материалы:

- 1) кетгут → шелк → кетгут → шелк;
- 2) шелк → кетгут → кетгут → шелк;**
- 3) шелк → кетгут → шелк → кетгут;
- 4) шелк → шелк → кетгут → кетгут;
- 5) кетгут → кетгут → шелк → шелк.

9.322 (УНПО) При наложении межкишечного анастомоза по Пирогову-Черни в первый ряд швов захватывают:

- 1) слизистые слои;
- 2) слизисто-подслизистые слои;
- 3) серозно-мышечные слои;
- 4) серозно-мышечно-подслизистые слои;**
- 5) все слои.

9.323 (УНПО) При выполнении кишечного шва механическую прочность его создает оболочка кишки:

- 1) слизистая;
- 2) подслизистая;**
- 3) мышечная;
- 4) серозная;
- 5) слизистая и серозная.

9.324 (УНПО) При наложении кишечного шва Ламбера захватывают:

- 1) слизистые слои;
- 2) слизисто-подслизистые слои;
- 3) серозно-мышечные слои;**
- 4) серозно-мышечно-подслизистый слой;
- 5) все слои.

9.325 (УНПО) При наложении шва Ламбера используется любой шовный материал, за исключением:

- 1) шелка;
- 2) кетгута;**
- 3) капрона;
- 4) дакрона;
- 5) лавсана.

9.326 (УНПО) При наложении шва Пирогова используется любой шовный материал, за исключением:

- 1) шелка;
- 2) кетгута;**
- 3) капрона;
- 4) дакрона;
- 5) лавсана.

9.327 (УНПО) При наложении кишечного шва Пирогова захватывают:

- 1) слизистые слои;
- 2) слизисто-подслизистые слои;
- 3) серозно-мышечные слои;
- 4) серозно-мышечно-подслизистые слои;**
- 5) все слои.

9.328 (УНПО) При наложении кишечного шва Бира захватывают:

- 1) слизистые слои;
- 2) слизисто-подслизистые слои;
- 3) серозно-мышечные слои;**
- 4) серозно-мышечно-подслизистые слои;
- 5) все слои.

9.329 (УНПО) При наложении шва Бира используется любой шовный материал, за исключением:

- 1) шелка;
- 2) кетгута;**
- 3) капрона;
- 4) дакрона;
- 5) лавсана.

9.330 (УНВПО) Однорядный кишечный шов можно накладывать на следующие отделы желудочно-кишечного тракта:

- 1) пищевод;**
- 2) желудок;**
- 3) тонкую кишку;**
- 4) толстую кишку;
- 5) все отделы.

9.331 (УНПО) Герметичность кишечного шва обеспечивается широким соприкосновением:

- 1) краев слизистой оболочки;
- 2) краев подслизистой оболочки;
- 3) краев мышечной оболочки;
- 4) краев серозной оболочки;
- 5) краев мышечной и серозной оболочек.**

9.332 (УНПО) Гемостатичность кишечного шва обеспечивает оболочка кишки:

- 1) слизистая;
- 2) подслизистая;**
- 3) мышечная;
- 4) серозная;
- 5) слизистая и серозная.

9.333 (УНПО) При выполнении холецистостомии дренажную трубку вводят в:

- 1) дно желчного пузыря;**
- 2) шейку желчного пузыря;

- 3) пузырьный проток;
- 4) желчный пузырь через паренхиму печени;
- 5) ни один из вариантов.

9.334 (УНПО) После выполнения холецистостомии для предупреждения желчного перитонита необходимо:

- 1) вывести пузырь на кожу и фиксировать к ней;
- 2) достаточно кисетного шва на пузыре вокруг стомы;
- 3) подшить пузырь к париетальному листку брюшины;**
- 4) подшить пузырь к косой мышце живота;
- 5) подшить к кисетному шву сальник на ножке.

9.335 (УНВПО) Удаление желчного пузыря от дна обусловлено:

- 1) внутрипеченочным его расположением;
- 2) брыжеечной организацией его ложа;
- 3) невозможностью выделения его протока в печеночно-12-перстной связке;**
- 4) невозможностью выделения пузырной артерии из воспалительного конгломерата;**
- 5) наличия камня в пузырном протоке.

9.336 (УНПО) Типичные сложности при выделении и перевязке пузырной артерии при холецистэктомии заключаются:

- 1) в ранении паренхимы печени;
- 2) в ошибочной перевязке правой печеночной артерии;**
- 3) в ошибочной перевязке общего желчного протока;
- 4) в ошибочной перевязке общего печеночного протока;
- 5) в ошибочной перевязке левой печеночной артерии.

9.337 (УНВПО) После холецистэктомии ложе пузыря обычно закрывают:

- 1) пластинкой фасции;
- 2) частью мышцы от передней брюшной стенки;
- 3) частью большого сальника;**
- 4) остатками серозного покрова желчного пузыря;**
- 5) паренхимой печени с помощью стягивающих швов.

9.338 (УНПО) После выполнения основного этапа холецистэктомии необходимо подвести наружный дренаж к:

- 1) 12-перстной кишке;
- 2) сальниковому отверстию;
- 3) ложу желчного пузыря;**
- 4) общему желчному протоку;
- 5) подкожножировой клетчатке.

9.339 (УНПО) При отыскании среднего отдела левого мочеточника в брюшной полости ориентиром служит:

- 1) латеральный край нисходящей ободочной кишки;
- 2) медиальный край нисходящей ободочной кишки;
- 3) верхний сигмовидный щелевидный карман;**
- 4) нижний сигмовидный щелевидный карман;
- 5) корень брыжейки тонкой кишки.

9.340 (УНПО) Кровоснабжение сигмовидной кишки осуществляется из бассейна артерии:

- 1) верхней брыжеечной;
- 2) общей подвздошной;
- 3) внутренней подвздошной;
- 4) нижней брыжеечной;**

5) наружной подвздошной.

9.341 (УНПО) Венозный отток от сигмовидной кишки осуществляется в систему вены:

- 1) воротной;**
- 2) нижней полой и воротной;
- 3) нижней полой;
- 4) воротной и верхней полой;
- 5) верхней полой.

9.342 (УНПО) Лимфоотток от сигмовидной кишки осуществляется в лимфоузлы по ходу:

- 1) аорты;
- 2) нижней полой вены;
- 3) верхней брыжеечной вены;
- 4) нижней брыжеечной вены;**
- 5) внутренней подвздошной вены.

9.343 (УНВПО) При ушивании раны печени можно использовать:

- 1) одиночные кетгутовые швы;**
- 2) закрытие раны пластинкой фасции;**
- 3) узловые шелковые швы;
- 4) пластику свободным сальником;**
- 5) пластику сальником на ножке.**

9.344 (УНПО) Гемостатический шов Кузнецова-Пенского используется для ушивания ран:

- 1) кожи;
- 2) мышц;
- 3) апоневроза;
- 4) кишки;
- 5) печени.**

9.345 (УНВПО) Гемостатический шов Кузнецова-Пенского используют при резекциях печени:

- 1) типичной;
- 2) атипичной;**
- 3) клиновидной;**
- 4) поперечной;**
- 5) гемигепатэктомии.

9.346 (УНПО) При операции на печени и внепеченочных желчных путях используются все оперативные доступы, за исключением:

- 1) Рио-Бранко;
- 2) Виноградова;**
- 3) Федорова;
- 4) Кохера;
- 5) правого торако-абдоминального.

9.347 (УНВПО) Тотальная ваготомия предполагает:

- 1) пересечение левого ствола вагуса над диафрагмой;
- 2) пересечение левого и правого стволов вагуса тотчас ниже диафрагмы;**
- 3) пересечение левого ствола вагуса тотчас ниже диафрагмы;**

- 4) пересечение левого ствола вагуса ниже отхождения его печеночной ветви;
- 5) пересечение ветвей вагуса, отходящих к телу желудка.

9.348 (УНПО) Селективная ваготомия предполагает:

- 1) **пересечение левого ствола вагуса ниже отхождения его печеночной ветви;**
- 2) пересечение ветвей вагуса, отходящих к телу желудка;
- 3) пересечение ветвей вагуса, отходящих к дну и телу желудка;
- 4) пересечение левого ствола вагуса выше отхождения печеночной его ветви;
- 5) ни один из вариантов.

9.349 (УНПО) Еюностомия по Витцелю с целью кормления больного предполагает:

- 1) фиксацию трубки аборально в просвете верхних 10-12 см тощей кишки;
- 2) фиксацию трубки орально в просвете верхних 20-25 см тощей кишки;
- 3) фиксацию трубки орально в просвете верхних 40 см тощей кишки;
- 4) **фиксацию трубки аборально в просвете верхних 40 см тощей кишки;**
- 5) фиксацию трубки аборально в просвете верхних 20-25 см тощей кишки.

9.350 (УНПО) При резекции тонкой кишки этап её мобилизации включает:

- 1) рассечение париетального листка брюшины для создания подвижности кишки;
- 2) пересечение приводящего конца удаляемой кишки;
- 3) пересечение отводящего конца удаляемой кишки;
- 4) **отделение от удаляемой части кишки брыжейки после предварительной перевязки её сосудов;**
- 5) пересечение отводящего и приводящего концов удаляемой кишки.

9.351 (УНПО) Техническим недостатком энтероэнтероанастомоза «конец в конец» при сравнении с соустьем «бок в бок» может быть:

- 1) сложность формирования задней губы анастомоза;
- 2) **сужение просвета анастомоза;**
- 3) сложность формирования передней губы анастомоза;
- 4) низкая прочность анастомоза;
- 5) низкая асептичность анастомоза.

9.352 (УНВПО) Техническими недостатками энтероэнтероанастомоза «бок в бок» при сравнении с соустьем «конец в конец» являются все, за исключением:

- 1) формирования слепого кармана у приводящей и отводящей культей кишки;
- 2) **широкого диаметра анастомоза;**
- 3) трехкратного числа швов при формировании соустья;
- 4) **сложности формирования передней губы анастомоза;**
- 5) **сложности формирования задней губы анастомоза.**

9.353 (УНПО) Для предупреждения инвагинации слепых концов культи после наложения энтероэнтероанастомоза «бок в бок» необходимо:

- 1) подшить концы культи к большому сальнику;
- 2) подшить концы культи к соседней петле тонкой кишки;
- 3) подшить анастомоз к близлежащему отделу ободочной кишки;
- 4) **подшить концы культи к приводящему и отводящему отделам кишки (выше и ниже анастомоза);**
- 5) подшить анастомоз к переднему листку париетальной брюшины брюшной стенки.

9.354 (УНПО) При проведении ретроградной аппендэктомии следующим действием хирурга после проведения лигатуры в брыжейке у основания отростка, его перевязки будет:

- 1) наложение Z-образного шва;
- 2) выделение отростка от основания к верхушке с рассечением и перевязкой брыжейки и спаек;
- 3) наложение кисетного шва вокруг основания отростка;**
- 4) пересечение отростка дистальнее места перевязки и погружение культи в кисет;
- 5) удаление отростка, послойное ушивание раны.

9.355 (УНПО) При проведении ретроградной аппендэктомии следующим действием хирурга после наложения кисетного шва вокруг основания отростка и погружения культи в кисет будет:

- 1) проведение лигатуры в брыжейке у основания отростка, его перевязка;
- 2) пересечение отростка дистальнее места перевязки;
- 3) наложение Z-образного шва;**
- 4) выделение отростка от основания к верхушке с рассечением и перевязкой брыжейки и спаек;
- 5) удаление отростка, послойное ушивание раны.

9.356 (УНПО) При проведении ретроградной аппендэктомии следующим действием хирурга после наложения Z-образного шва будет:

- 1) проведение лигатуры в брыжейке у основания отростка, его перевязка;
- 2) наложение кисетного шва вокруг основания отростка;
- 3) выделение отростка от основания к верхушке с рассечением и перевязкой брыжейки и спаек;**
- 4) пересечение отростка дистальнее места перевязки и погружения культи в кисет;
- 5) удаление отростка, послойное ушивание раны.

9.357 (УНПО) При проведении ретроградной аппендэктомии следующим действием хирурга после выделения отростка от основания к верхушке с рассечением и перевязкой брыжейки и спаек будет:

- 1) проведение лигатуры в брыжейке у основания отростка, его перевязка;
- 2) наложение кисетного шва вокруг основания отростка;
- 3) ушивание раны брюшной полости;**
- 4) наложение Z-образного шва;
- 5) пересечения отростка дистальнее места перевязки и погружение культи в кисет.

9.358 (УНПО) При выполнении резекции желудка по Гофмейстеру-Финстереру следующим действием хирурга после мобилизации желудка будет:

- 1) удаление 1/2 части желудка;
- 2) подведение к культе желудка через окно в брыжейке поперечноободочной кишки петли тощей кишки длиной до 10 см;
- 3) подшивание кишки на всем протяжении к культе желудка изоперистальтично серозно-мышечными швами;
- 4) вскрытие просвета кишки, равного диаметру просвета желудка, наложение соустья по правилу двухрядного кишечного шва;**
- 5) фиксация культи желудка в mesocolon.

9.359 (УНВПО) Для предупреждения заброса желудочного содержимого в приводящий отдел 12-перстной кишки при резекции желудка по Гофмейстеру-Финстереру необходимо:

- 1) взять петлю тощей кишки 30-40 см;
- 2) фиксировать место анастомоза в mesocolon;
- 3) наложить серозно-мышечные швы между приводящим отделом кишки и культей желудка выше будущего анастомоза;
- 4) наложить серозно-мышечные швы между отводящим отделом кишки и культей желудка ниже будущего анастомоза;
- 5) сформировать «шпору» из приводящего отдела кишки.

9.360 (УНВПО) Основная идея пилоропластики при пилоростенозе заключается:

- 1) в продольном рассечении пилорического отдела желудка до слизистого слоя;
- 2) в продольном сквозном рассечении пилорического отдела желудка и последующего ушивания в поперечном направлении;
- 3) в продольном, проникающем в просвет органа, рассечении пилорического отдела желудка и последующем его ушивании в поперечном направлении;
- 4) замене пилорического отдела желудка фрагментом тонкой кишки на питающей сосудистой ножке;
- 5) замене пилорического отдела желудка фрагментом толстой кишки на питающей сосудистой ножке.

9.361 (УНПО) Развитие «порочного круга» после выполнения гастроэнтероанастомоза обусловлено:

- 1) широким диаметром анастомоза;
- 2) изоперистальтическим подшиванием кишки;
- 3) стабильностью положения анастомоза как во время операции, так и после неё;
- 4) «слипанием» приводящего и отводящего отделов кишки с формированием «шпоры»;
- 5) наложением дополнительного межкишечного соустья по Брауну;

9.362 (УНПО) «Порочный круг» после выполнения гастроэнтероанастомоза обусловлен:

- 1) узким диаметром анастомоза или выраженным анастомозитом;
- 2) изоперистальтическим подшиванием кишки к желудку;
- 3) формированием «шпоры» на приводящей петле кишки выше анастомоза;
- 4) подшиванием к желудку приводящего отдела кишки выше анастомоза;
- 5) наложением дополнительного межкишечного соустья по Брауну.

9.363 (УНПО) «Порочный круг» после выполнения гастроэнтероанастомоза обусловлен:

- 1) широким диаметром анастомоза;
- 2) антиперистальтическим подшиванием кишки к желудку;
- 3) стабильностью положения анастомоза как во время операции, так и после неё;
- 4) формированием «шпоры» на приводящей петле кишки выше анастомоза;
- 5) подшиванием к желудку приводящего отдела кишки выше анастомоза.

9.364 (УНПО) «Порочный круг» после выполнения гастроэнтероанастомоза на длинной приводящей петле обусловлен:

- 1) широким диаметром анастомоза;
- 2) изоперистальтическим подшиванием кишки к желудку;
- 3) подшиванием к желудку приводящего отдела кишки ниже анастомоза;
- 4) подшиванием к желудку приводящего отдела кишки выше анастомоза;
- 5) формированием «шпоры» на приводящей петле кишки выше анастомоза.

9.365 (УНПО) «Порочный круг» после выполнения гастроэнтероанастомоза обусловлен:

- 1) изоперистальтическим подшиванием кишки к желудку;
- 2) формированием «шпоры» на приводящей петле кишки выше анастомоза;
- 3) подшиванием к желудку приводящего отдела кишки выше анастомоза;
- 4) **отсутствием дополнительного межкишечного соустья по Брауну;**
- 5) ни один из вариантов.

9.366 (УНПО) При множественных близко расположенных ранах петли кишки целесообразно выполнить:

- 1) зашивание каждой раны однорядным кишечным швом (Ламбер или Бир);
- 2) зашивание каждой раны двухрядным кишечным швом (Шмиден + Ламбер или Жели + Ламбер);
- 3) **экономную резекцию кишки в пределах ранения;**
- 4) обширную резекцию кишки с захватом не менее 20 см приводящего и 20 см отводящего концов;
- 5) обширную резекцию кишки с захватом не менее 20 см приводящего и 10 см отводящего концов;

9.367 (УНПО) Следующим действием хирурга при выполнении классической неосложненной аппендэктомии после нахождения илеоцекального угла будет:

- 1) **выведение отростка в рану;**
- 2) перевязка сосудов брыжейки у основания отростка;
- 3) отсечение брыжейки от отростка;
- 4) наложение лигатуры на основание отростка и его отсечение;
- 5) наложение кисетного шва на купол слепой кишки вокруг основания отростка, погружение культи отростка в кисет.

9.368 (УНПО) При затруднениях в отыскании червеобразного отростка следует ориентироваться на:

- 1) купол слепой кишки;
- 2) верхний край илеоцекального угла;
- 3) начало восходящей ободочной кишки;
- 4) **свободную ленту;**
- 5) нижний край илеоцекального угла.

9.369 (УНПО) Ретроградное удаление червеобразного отростка обусловлено:

- 1) тазовым его расположением;
- 2) **невозможностью первоначального выделения его из спаек с окружающими тканями;**
- 3) флегмонозной формой его воспаления;
- 4) ничем не обусловлено;
- 5) выраженной инфильтрацией купола слепой кишки.

9.370 (УНПО) При точечной (колотой) проникающей ране тонкой кишки необходимо выполнить:

- 1) наложение одного ряда отдельных узловых серозно-мышечных швов;
- 2) **наложение серозно-мышечного кисетного шва с погружением краев раны в просвет кишки;**
- 3) наложение двухрядного кишечного шва (Шмиден+Ламбер);
- 4) наложение двухрядного кишечного шва (Жели+Ламбер);
- 5) экономную резекцию кишки.

9.371 (УНПО) При образовании раны тонкой кишки, превышающей по размеру её диаметр, необходимо выполнить:

- 1) наложение одного ряда отдельных узловых серозно-мышечных швов в продольном направлении;
- 2) наложение двухрядного кишечного шва (Шмиден+Ламбер) в продольном направлении;
- 3) наложение двухрядного кишечного шва (Жели+Ламбер) в продольном направлении;
- 4) наложение двухрядного кишечного шва (Шмиден+Ламбер) в поперечном направлении;
- 5) экономную резекцию кишки.

9.372 (УНПО) Еюностомия по Витцелю предполагает фиксацию кишки к передней брюшной стенке следующим образом:

- 1) соединением краев разреза париетальной брюшины со стенкой кишки в области стомы;
- 2) соединением краев разреза прямой мышцы живота со стенкой кишки в области стомы;
- 3) соединением краев разреза париетальной брюшины и прямой мышцы живота со стенкой кишки в области стомы;
- 4) соединением краев апоневроза наружной и внутренней косых мышц живота со стенкой кишки в области стомы;
- 5) соединением краев кожи со стенкой кишки в области стомы.

9.373 (УНПО) «Разгрузочная» илеостомия при непроходимости нижележащей кишки предполагает подшивание подвздошной кишки к брюшной стенке следующим образом:

- 1) края рассеченной париетальной брюшины сшиваются с периферией купола выведенной кишки, края стенки вскрытой кишки с краями кожи;
- 2) края рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота сшиваются с периферией купола выведенной кишки, края вскрытой стенки кишки с краями кожи;
- 3) края внутренней косой и поперечной мышц живота сшиваются с периферией купола выведенной кишки, края вскрытой стенки кишки с краями кожи.

9.374 (УНПО) При выполнении гастростомии по Штаму-Кадеру следующим действием хирурга после выведения в рану передней стенки желудка будет:

- 1) наложение трех концентрических кисетных швов на стенку желудка;
- 2) рассечение стенки желудка в центре внутреннего кисетного шва, введение трубки;
- 3) натягивание последовательно кисетных швов, создавая наружный конус из желудка вокруг трубки;
- 4) выведение трубки наружу и фиксация стенки желудка к париетальной брюшине;
- 5) ушивание послойно операционной раны.

9.375 (УНПО) При выполнении гастростомии по Топроверу следующим действием хирурга после выведения в рану передней стенки желудка будет:

- 1) вскрытие просвета в центре внутреннего кисетного шва и введение трубки;
- 2) наложение двух лигатур-держалок на стенку желудка;
- 3) наложение трех концентрических кисетных швов на стенку желудка;
- 4) последовательное завязывание кисетных швов, создание наружного конуса из желудка вокруг трубки;
- 5) подшивание стенки желудка к краю кожи.

9.376 (УНПО) При выполнении гастростомии по Топроверу следующим действием хирурга после наложения трех концентрических кисетных швов на стенку желудка будет:

- 1) рассечение стенки желудка в центре внутреннего кисетного шва, введение трубки;
- 2) последовательное завязывание кисетных швов, погружение трубки в желудок;
- 3) подшивание стенки желудка к краю кожи;
- 4) послойное зашивание трансректального разреза до гастростомы;

- 5) фиксация трубки к коже.

9.377 (УНПО) При выполнении гастроэнтероанастомоза прием Губарева используют для отыскания:

- 1) корня брыжейки тонкой кишки;
- 2) корня брыжейки поперечной ободочной кишки;
- 3) поджелудочной железы;
- 4) начала тонкой кишки;**
- 5) илеоцекального угла.

9.378 (УНПО) Техника резекции желудка по способу Полия-Райхель отличается от способа Полия-Бальфур только тем, что:

- 1) петля тощей кишки подводится к культе желудка впереди поперечной ободочной кишки;**
- 2) приводящее колено тощей кишки дополнительно подшивается к культе желудка выше анастомоза;
- 3) на приводящей петле тощей кишки формируется «шпора»;
- 4) тощую кишку анастомозируют с гофрированной культей желудка;
- 5) нет отличий.

9.379 (УНПО) Резекция желудка по Бильрот-1 предполагает следующую реконструкцию:

- 1) гастродуоденоанастомоз «конец в конец» после формирования просвета культи желудка;**
- 2) гастродуоденоанастомоз «конец в конец» после инверсии 12-перстной кишки (антиперистальтическое подшивание), далее дуоденодуоденоанастомоз;
- 3) передний гастроеюноанастомоз «конец в бок» со сформированным просветом культи желудка и формированием культи 12-перстной кишки.

9.380 (УНПО) Резекция желудка по Бильрот-2 предполагает следующую реконструкцию:

- 1) передний гастроеюноанастомоз «конец в бок» с гофрированным просветом культи желудка и формированием культи 12-перстной кишки;
- 2) передний гастроеюноанастомоз «бок в бок» после формирования культей 12-перстной кишки и желудка;**
- 3) гастродуоденоанастомоз «конец в конец» после формирования просвета культи желудка.

9.381 (УНПО) Оперативный доступ к внепеченочным желчным путям по способу Рио-Бранко предполагает:

- 1) верхнесрединную лапаротомию с продолжением разреза вправо и вверх к концу X ребра;**
- 2) волнообразный разрез: верхняя срединная лапаротомия до середины расстояния между мечевидным отростком и пупком, далее вправо под углом 90 градусов, затем параректально до уровня пупка;
- 3) верхнесрединную лапаротомию с продолжением разреза вправо под углом 90 градусов;
- 4) Т-образный разрез, состоящий из правого параректального разреза и разреза вдоль реберной дуги;
- 5) дугообразный разрез выпуклостью вниз вдоль правой реберной дуги.

9.382 (УНПО) Оперативный доступ к внепеченочным желчным путям по способу Кохера предполагает:

- 1) разрез от мечевидного отростка по белой линии длиной 4-5 см, далее параллельно правой реберной дуге;
- 2) разрез от мечевидного отростка параллельно правой реберной дуге;**

- 3) верхнесрединную лапаротомию с продолжением разреза вправо под углом 90 градусов;
- 4) Т-образный разрез, состоящий из правого параректального разреза и разреза вдоль реберной дуги;
- 5) дугообразный разрез выпуклостью вниз вдоль правой реберной дуги.

9.383 (УНПО) Оперативный доступ к внепеченочным желчным путям по способу Федорова предполагает:

- 1) **разрез от мечевидного отростка по белой линии длиной 4-5 см, далее параллельно правой реберной дуге;**
- 2) разрез от мечевидного отростка параллельно правой реберной дуге;
- 3) верхнесрединную лапаротомию с продолжением разреза вправо под углом 90 градусов;
- 4) Т-образный разрез, состоящий из правого параректального разреза и разреза вдоль реберной дуги;
- 5) дугообразный разрез выпуклостью вниз вдоль правой реберной дуги.

9.384 (УНВПО) К операциям создания портокавальных анастомозов относят:

- 1) **наложение соустья между верхней брыжеечной и нижней полой венами;**
- 2) наложение соустья между непарной и правой почечной венами;
- 3) **между селезеночной и левой почечной венами;**
- 4) между яичковой и общей подвздошной венами.

9.385 (УНВПО) Создание портокавальных органоанастомозов осуществляют путем:

- 1) **оменторенопексии;**
- 2) **операции Тальма;**
- 3) операции по Витцелю;
- 4) операции по Захарову;
- 5) **оментогепатодиафрагмопексии.**

9.386 (УНПО) Создание дренажей для отведения асцитической жидкости проводят

- 1) операцией Тальма;
- 2) операцией Экка;
- 3) **операцией Кальба.**

9.387 (УНВПО) При травмах, сопровождающихся разрывами печени, необходимо произвести:

- 1) **удаление сгустков крови и свободно лежащих кусков печеночной ткани;**
- 2) срочное наложение ряда кетгутовых швов на печень;
- 3) **экономное иссечение нежизнеспособных участков печени;**
- 4) удаление печени как источника кровотечения.

9.388 (УНВПО) Решающую роль в фиксации печени играют:

- 1) серповидная связка;
- 2) венечная связка;
- 3) **нижняя полая вена;**
- 4) **кишечник;**
- 5) **внебрюшинное поле печени.**

9.389 (УНВПО) Каждая доля печени имеет доступную для хирургической обработки глиссонову ножку, представленную:

- 1) печеночным протоком;**
- 2) печеночной венной;
- 3) желчным протоком;
- 4) ветвью воротной вены;**
- 5) печеночной артерией.**

9.390 (УНВПО) К сосудистой ножке подход может быть осуществлен через:

- 1) малососудистые борозды;**
- 2) венечную связку;
- 3) треугольную связку печени;**
- 4) ворота печени.

9.391 (УНВПО) Приносящими сосудами для печени являются:

- 1) печеночная вена;
- 2) печеночная артерия;**
- 3) нижняя полая вена;
- 4) воротная вена;**
- 5) пупочная вена.**

9.392 (УНПО) Возможно ли полное восстановление коллатерального кровообращения при перевязке одной из ветвей печеночной артерии:

- 1) да;
- 2) нет;**
- 3) иногда.

9.393 (УНВПО) При выполнении радикальных операций на печени учитывается:

- 1) положение треугольных связок печени;
- 2) распределение желчных протоков;**
- 3) распределение ветвей воротной вены и печеночной артерии;**
- 4) распределение печеночных вен;
- 5) положение круглой связки печени.

9.394 (УНПО) При каком положении печени легче выйти к ее воротам:

- 1) дорсопетаальном;**
- 2) вентропетаальном.

5.395 (УНПО) Воротная вена подходит к печени в толще:

- 1) печеночно-двенадцатиперстной связки;**
- 2) печеночно-желудочной связки;
- 3) серповидной связки;
- 4) венечной связки;
- 5) треугольной связки;
- 6) круглой связки.

9.396 (УНВПО) Рентгенологическое исследование портального кровообращения возможно путем:

- 1) спленопортографии;**
- 2) ренопортографии;
- 3) пупочной портографии;**

- 4) создания пневмоперитонеума.

9.397 (УНВПО) К атипичным резекциям печени относятся:

- 1) гемигепатэктомия;
- 2) расширенная резекция печени;
- 3) **клиновидная резекция;**
- 4) **краевая резекция;**
- 5) **плоскостная резекция;**
- 6) **поперечная резекция.**

9.398 (УНВПО) При эхинококкозе печени показана:

- 1) сегментэктомия;
- 2) **расширенная резекция печени;**
- 3) атипичная резекция печени;
- 4) типичная резекция печени;
- 5) **операция экскохлеации.**

9.399 (УНВПО) При опухолях печени на ножке показана:

- 1) сегментэктомия;
- 2) **плоскостная резекция;**
- 3) **атипичная резекция;**
- 4) типичная резекция;
- 5) операция экскохлеации.

9.400 (УНПО) С целью остановки кровотечения производят сдавление гепато-дуоденальной связки не более, чем на:

- 1) 3 мин;
- 2) **15 мин;**
- 3) 25 мин;
- 4) 40 мин.

9.401 (УНПО) Переднее и заднее печеночное сплетение располагаются:

- 1) **между листками печеночно-дуоденальной связки;**
- 2) переднее – на диафрагмальной поверхности печени, заднее – на висцеральной;
- 3) переднее – вдоль переднего края печени, заднее – вдоль заднего.

9.402 (УНПО) При абсцессах печени внеплевральный внебрюшинный доступ для дренирования гнойников осуществляется:

- 1) в области гепато-дуоденальной связки;
- 2) **в области внепеченочного поля печени;**
- 3) в области прикрепления серповидной связки;
- 4) через малый сальник.

9.403 (УНПО) При сдавлении печеночной артерии цвет печени меняется на:

- 1) черный;
- 2) ярко-красный;
- 3) **багрово-фиолетовый;**
- 4) синий.

9.404 (УНПО) Спереди сальниковое отверстие ограничивает:

- 1) печеночно-желудочная связка;
- 2) **печеночно-дуоденальная связка;**
- 3) желудочно-диафрагмальная связка.

9.405 (УНПО) «Ножка», состоящая из ветви воротной вены, печеночной артерии и печеночного протока, носит название:

- 1) **Глиссоновой;**

- 2) Гисса;
- 3) Пирогова.

9.406 (УНПО) Сегменты печени отделены друг от друга:

- 1) зонами, богатыми артериальными сосудами;
- 2) **малососудистыми бороздами;**
- 3) ветвями нижней полой вены.

9.407 (УНВПО) Одновременно секторами и сегментами печени являются все, кроме:

- 1) **3 и 4;**
- 2) 2 и 1;
- 3) **5 и 7;**
- 4) 6 и 7.

9.408 (УНВПО) К секторам печени, состоящим из одного сегмента, относят:

- 1) левый парамедианный;
- 2) **левый латеральный;**
- 3) правый парамедианный;
- 4) правый латеральный;
- 5) **дорсальный.**

9.409 (УНПО) Выберите вариант в порядке увеличения элементов печени:

- 1) сектор – сегмент – доля – орган;
- 2) **сегмент – сектор – доля – орган;**
- 3) доля – сегмент – сектор;
- 4) сегмент 1 порядка – сегмент 2 порядка – сектор – доля.

9.410 (УНПО) Воротная вена делится вблизи печени на 2 ветви:

- 1) верхнюю и нижнюю;
- 2) **правую и левую;**
- 3) переднюю и заднюю.

9.411 (УНВПО) Внутривенные ветви воротной вены располагаются в печени по ходу отростков:

- 1) **фиброзной капсулы;**
- 2) **глиссоновой капсулы;**
- 3) серозной капсулы.

9.412 (УНПО) Печеночные вены впадают в:

- 1) общую печеночную вену;
- 2) воротную вену;
- 3) **нижнюю полую вену;**
- 4) верхнюю брыжеечную вену;
- 5) верхнюю полую вену.

9.413 (УНВПО) Иннервация печени осуществляется:

- 1) **правым диафрагмальным нервом;**
- 2) **солнечным сплетением;**
- 3) **обоими стволами блуждающих нервов;**
- 4) правым стволом блуждающего нерва;
- 5) левым диафрагмальным нервом.

9.414 (УНПО) Основными регионарными лимфоузлами печени 2-го этапа являются

- 1) грудные лимфоузлы;
- 2) чревные лимфоузлы;**
- 3) лимфоузлы по ходу нижней брыжеечной артерии;
- 4) внутрипеченочные лимфоузлы.

9.415 (УНВПО) Регионарными лимфоузлами 1-го этапа для отводящих лимфатических сосудов печени являются:

- 1) печеночные лимфоузлы;**
- 2) чревные лимфоузлы;
- 3) лимфоузлы по ходу левой желудочной артерии;**
- 4) грудные лимфоузлы;
- 5) лимфоузлы, расположенные вокруг аорты и нижней полой вены.**

9.416 (УНПО) Для временной остановки кровотечения можно использовать все приемы, кроме:

- 1) пальцевое сдавление печени;
- 2) наложение эластических зажимов;
- 3) временное сдавление печеночно-дуоденальной связки;
- 4) ни один из предложенных вариантов.**

9.417 (УНВПО) При операциях на печени используются все швы, за исключением:

- 1) Кузнецова-Пенского;
- 2) Джиордано;
- 3) Оппеля;
- 4) Ламбера;**
- 5) Жели.**

9.418 (УНВПО) К физическим методам остановки незначительного печеночного кровотечения относятся:

- 1) электрокоагуляция;**
- 2) воздействие лучом лазера;**
- 3) горячие компрессы;**
- 4) тампонада сальником;
- 5) применение гемостатической губки.

9.419 (УНВПО) Целью трансумбиликальной катетеризации пупочной вены является:

- 1) введение рентгенконтрастных растворов в систему воротной вены;**
- 2) введение дренажных трубок в систему воротной вены;
- 3) введение лекарственных растворов в систему воротной вены;**
- 4) введение лекарственных веществ в систему нижней полой вены.

9.420 (УНВПО) Осложнением трансумбиликальной катетеризации пупочной вены является:

- 1) возможность перфорации вены в области ворот печени;**
- 2) желчеистечение;
- 3) расслоение стенки вены;**
- 4) возникновение острой кишечной непроходимости;
- 5) венозное кровотечение.**

9.421 (УНПО) В печеночно-дуоденальной связке общий желчный проток располагается:

- 1) справа от печеночной артерии;**

- 2) слева от печеночной артерии;
- 3) позади печеночной артерии.

9.422 (УНВПО) Общий желчный проток открывается:

- 1) на уровне середины нисходящей части двенадцатиперстной кишки;
- 2) на малом сосочке;
- 3) в восходящей части двенадцатиперстной кишки;
- 4) на вершине большого сосочка.

9.423 (УНПО) Пузырная артерия отходит от правой печеночной в пределах треугольника:

- 1) Шипо;
- 2) Калло;
- 3) Пирогова.

9.424 (УНВПО) Треугольник Калло образован:

- 1) пузырным протоком;
- 2) общим печеночным протоком;
- 3) желчным протоком;
- 4) правой печеночной артерией;
- 5) левой печеночной артерией;
- 6) пузырной артерией.

9.425 (УНВПО) Желчный пузырь имеет:

- 1) головку;
- 2) шейку;
- 3) тело;
- 4) дно;
- 5) пузырный проток.

9.426 (УНПО) Желчный пузырь может располагаться:

- 1) интраперитонеально;
- 2) мезоперитонеально;
- 3) внутрипеченочно;
- 4) внепеченочно;
- 5) все ответы верны.

9.427 (УНВПО) К оперативным приемам, выполняемым на желчном пузыре, могут быть отнесены:

- 1) холедоходуоденостомия;
- 2) холецистотомия;
- 3) холецистостомия;
- 4) холедохотомия;
- 5) холецистэктомия.

9.428 (УНВПО) К операциям на желчном протоке относятся:

- 1) холедоходуоденостомия;
- 2) холецистотомия;
- 3) холецистостомия;
- 4) холедохотомия;
- 5) холецистэктомия.

9.429 (УНВПО) Холецистотомию применяют для:

- 1) наложения свища желчного пузыря;
- 2) удаления одиночных крупных камней из желчного пузыря;
- 3) вскрытия желчного пузыря;

- 4) дренирования желчного протока.

9.430 (УНВПО) Холецистостомию применяют:

- 1) как этап при удалении желчного пузыря;
- 2) для наложения свища желчного пузыря;
- 3) для удаления камней желчного пузыря;
- 4) при невозможности проведения холецистэктомии из-за тяжести общего состояния больного.

9.431 (УНВПО) Холедохотомию выполняют:

- 1) при наличии камней в желчном протоке;
- 2) для дренирования протока при холангите;
- 3) всегда в ходе холецистэктомии.

9.432 (УНВПО) Холедохотомия может быть:

- 1) супрадуоденальная;
- 2) ретродуоденальная;
- 3) трансдуоденальная;
- 4) подпеченочная.

9.433 (УНПО) Интраоперационная холангиография является обязательным условием перед проведением холедохотомии:

- 1) обязательным;
- 2) не обязательным;
- 3) по усмотрению хирурга.

9.434 (УНВПО) Холецистодуоденостомию выполняют:

- 1) для создания соустья между желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой;
- 2) для наложения свища желчного пузыря;
- 3) при непроходимости желчного протока;
- 4) для создания соустья между желчным протоком и двенадцатиперстной кишкой;
- 5) при холангите;
- 6) при опухоли головки поджелудочной железы.

9.435 (УНВПО) Обязательными условиями для выполнения холецистодуоденостомии являются:

- 1) полная проходимость пузырного протока;
- 2) полная проходимость печеночного протока;
- 3) интраперитонеальное положение желчного пузыря;
- 4) можно выполнять в любых условиях.

9.436 (УНВПО) Непроходимость желчного протока может быть вызвана:

- 1) раком фатерова сосочка;
- 2) рубцовыми изменениями желчного протока;
- 3) раком головки поджелудочной железы;
- 4) наличием камня в желчном протоке;
- 5) наличием камня в пузырном протоке;
- 6) опухолью печени.

9.437 (УНВПО) Холецистодуоденостомия:

- 1) является паллиативной операцией;
- 2) проводится при непроходимости желчного протока;
- 3) обеспечивает отток желчи;

- 4) является радикальной операцией;
- 5) является заключительным этапом холецистотомии.

9.438 (УНВПО) При холецистэктомии чаще используют доступ по:

- 1) Федорову;
- 2) Рио-Бранко;
- 3) Кохеру;
- 4) Волковичу-Дьяконову;
- 5) Бергману-Израэлю;

9.439 (УНПО) При калькулезном холецистите более предпочтительным является проведение холецистэктомии:

- 1) «от дна»;
- 2) «от шейки».

9.440 (УНПО) При холецистэктомии «от шейки» последовательно выделяют:

- 1) желчный пузырь, пузырный проток, пузырную артерию;
- 2) пузырную артерию, желчный пузырь, пузырный проток;
- 3) пузырный проток, пузырную артерию, желчный пузырь.

9.441 (УНПО) Лигирование пузырного протока в случаях его слияния с печеночным протоком под прямым углом производят на расстоянии от места их слияния:

- 1) 1-1,5 см;
- 2) 0,5-1,0 см;
- 3) 2-2,5 см.

9.442 (УНВПО) Неправильная перевязка пузырного протока может привести к:

- 1) деформации желчного протока;
- 2) возникновению симптомов «ложного холецистита»;
- 3) невозможности дальнейшего проведения операции;
- 4) перевязку можно производить в любом месте.

9.443 (УНПО) При холецистэктомии «от дна» последовательно выделяют:

- 1) желчный пузырь, пузырную артерию, пузырный проток;
- 2) пузырную артерию, желчный пузырь, пузырный проток;
- 3) пузырный проток, пузырную артерию, желчный пузырь.

9.444 (УНВПО) Показаниями к холецистэктомии являются:

- 1) все формы холецистита;
- 2) калькулезный холецистит;
- 3) прободение желчного пузыря;
- 4) некалькулезный холецистит при неэффективности консервативного лечения;
- 5) доброкачественные и злокачественные опухоли желчного пузыря.

9.445 (УНВПО) Противопоказаниями к лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) являются:

- 1) беременность;
- 2) ожирение 3-4 степени;
- 3) тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы;
- 4) калькулезный холецистит;
- 5) воспалительные процессы передней брюшной стенки.

9.446 (УНПО) Первым этапом при ЛХЭ является:

- 1) выделение желчного пузыря из ложа печени;

- 2) ревизия органов брюшной полости;
- 3) наложение пневмоперитонеума;**
- 4) перевязка пузырного протока.

9.447 (УНВПО) Для наложения пневмоперитонеума используют:

- 1) кислород;**
- 2) углекислый газ;**
- 3) закись азота;**
- 4) фторотан;
- 5) воздух;
- 6) инертные газы.**

9.448 (УНПО) Классические точки Калька расположены:

- 1) под мечевидным отростком;
- 2) на 3 см выше и ниже пупка и на 0,5 см справа и слева от срединной линии;**
- 3) справа и слева, в месте пересечения реберной дуги и среднеключичной линии;
- 4) на 5 см выше и ниже пупка по срединной линии.

9.449 (УНВПО) Достоверными признаками нахождения иглы в брюшной полости являются:

- 1) скорость поступления CO₂ (1,2-1,6 л/мин в норме);**
- 2) исчезновение печеночной тупости;**
- 3) появление крепитации;
- 4) все верно;
- 5) только субъективное ощущение «провала» при проколе брюшной стенки.

9.450 (УНПО) ЛХЭ у больных с гипертонической болезнью проводят под давлением:

- 1) 12-14 мм рт. ст.;
- 2) 6-8 мм рт. ст.;**
- 3) 2-4 мм рт. ст.;
- 4) 14-16 мм рт. ст.

9.451 (УНПО) Ревизия органов брюшной полости при выполнении ЛХЭ:

- 1) обязательна;**
- 2) никогда не проводится;
- 3) проводится по желанию хирурга;
- 4) проводится только при перфорации желчного пузыря.

9.452 (УНПО) Ревизию органов брюшной полости начинают с:

- 1) области малого таза;
- 2) правой боковой области живота;
- 3) правой половины верхнего этажа брюшной полости;**
- 4) области прикрепления брыжейки тонкой кишки;
- 5) принципиального значения не имеет.

9.453 (УНВПО) Рабочее положение операционного стола при ЛХЭ:

- 1) ножной конец опущен на 10-15 градусов;**
- 2) наклон стола вправо;
- 3) наклон стола влево;**
- 4) ножной конец поднят на 10-15 градусов.

9.454 (УНПО) Пневмоперитонеум достигается введением CO₂ в объеме:

- 1) 0,5 л;
- 2) 8-10 л;
- 3) 4-6 л.**

9.455 (УНВПО) Дренирование подпеченочного пространства проводят:

- 1) всегда;
- 2) в случае вскрытия пузыря при эмпиеме;
- 3) при повреждении ткани печени в ложе желчного пузыря;
- 4) при выделении пузыря из выраженного перипузырного инфильтрата.

9.456 (УНПО) Введение CO₂ в брюшную полость при ЛХЭ осуществляют через:

- 1) троакар;
- 2) иглу Вереша;
- 3) лапароскоп;
- 4) не имеет значения.

9.457 (УНПО) Срок послеоперационной госпитализации больного при ЛХЭ:

- 1) 1 месяц;
- 2) 2 недели;
- 3) больной в госпитализации не нуждается;
- 4) 3-5 дней.

9.458 (УНВПО) Преимущества лапароскопического вмешательства:

- 1) является малоинвазивным методом;
- 2) сокращение срока реабилитации больных;
- 3) хороший косметический эффект;
- 4) операцию может проводить врач не хирургического профиля;
- 5) не имеет противопоказаний.

9.459 (УНВПО) К поджелудочной железе может быть использован подход:

- 1) через желудочно-ободочную связку;
- 2) через малый сальник;
- 3) через печеночно-желудочную связку;
- 4) через брыжейку поперечной ободочной кишки;
- 5) через переднюю и заднюю стенки желудка.

9.460 (УНВПО) Целью операции при остром панкреатите является:

- 1) прекращение активации ферментов и дальнейшего разрушения железы;
- 2) предупреждение распространения воспалительного процесса на желчные пути;
- 3) создание широкого канала для свободного дренажа железы;
- 4) достижение хорошего косметического эффекта;
- 5) правильных ответов нет.

9.461 (УНПО) При опухолях поджелудочной железы используют операцию:

- 1) панкреатодуоденальной резекции;
- 2) гепатодуоденальной резекции;
- 3) панкреатолиенальной резекции.

9.462 (УНПО) Панкреатодуоденальная резекция при опухоли поджелудочной железы является операцией:

- 4) радикальной;
- 5) паллиативной.

9.463 (УНПО) Головка поджелудочной железы покрыта брюшиной:

- 1) интраперитонеально;
- 2) **экстраперитонеально;**
- 3) мезоперитонеально.

9.464 (УНВПО) Головка поджелудочной железы имеет:

- 1) **переднюю и заднюю поверхности;**
- 2) **передний и задний края;**
- 3) верхний и нижний края;
- 4) верхнюю и нижнюю поверхности;
- 5) медиальную и латеральную поверхности.

9.465 (УНВПО) Тело поджелудочной железы имеет:

- 1) **переднюю, заднюю, нижнюю поверхности;**
- 2) **передний, верхний и нижний края;**
- 3) переднюю, заднюю, верхнюю поверхности;
- 4) задний, верхний, нижний края.

9.466 (УНПО) Сальниковый бугор расположен на:

- 1) **передней поверхности поджелудочной железы;**
- 2) задней поверхности поджелудочной железы;
- 3) нижней поверхности поджелудочной железы.

9.467 (УНПО) Продольная борозда от селезеночной вены располагается на:

- 1) **задней поверхности поджелудочной железы;**
- 2) передней поверхности поджелудочной железы;
- 3) нижней поверхности поджелудочной железы.

9.468 (УНПО) Главный проток поджелудочной железы открывается в области:

- 1) малого сосочка двенадцатиперстной кишки;
- 2) **большого сосочка двенадцатиперстной кишки.**

9.469 (УНПО) Главный проток поджелудочной железы может соединяться с:

- 1) **общим желчным протоком;**
- 2) **общим печеночным протоком;**
- 3) **пузырным протоком.**

9.470 (УНПО) Дополнительный проток поджелудочной железы открывается:

- 1) **на малом сосочке двенадцатиперстной кишки;**
- 2) **на большом сосочке двенадцатиперстной кишки.**

9.471 (УНПО) Большой сосочек располагается в:

- 1) восходящей части 12-перстной кишки;
- 2) **нисходящей части 12-перстной кишки;**
- 3) луковице 12-перстной кишки.

9.472 (УНПО) Поджелудочная железа:

- 1) **малоподвижна;**
- 2) хорошо подвижна;
- 3) свободно выводится в операционную рану.

9.473 (УНВПО) Позади головки поджелудочной железы располагаются:

- 1) нижняя полая вена;**
- 2) аорта;
- 3) левая почка;
- 4) начальный отдел воротной вены.**

9.474 (УНВПО) Позади тела поджелудочной железы находятся:

- 1) верхняя брыжеечная артерия;**
- 2) нижняя полая вена;
- 3) аорта;**
- 4) часть солнечного сплетения;**
- 5) левая почка;
- 6) селезенка.

9.475 (УНПО) Позади хвоста поджелудочной железы находится:

- 1) левая почка;**
- 2) селезенка;
- 3) желудок;
- 4) левая доля печени.

9.476 (УНПО) Границами поясничной области является все перечисленное, кроме:

- 1) линия Лесгафта;
- 2) гребень подвздошной кости;
- 3) лонные бугорки;**
- 4) XII ребро;
- 5) линия остистых отростков.

9.477 (УНВПО) Собственная фасция спины покрывает:

- 1) квадратную мышцу поясницы;
- 2) наружную косую мышцу живота;**
- 3) внутреннюю косую мышцу живота;
- 4) широкую мышцу спины;**

9.478 (УНПО) Место вблизи гребня подвздошной кости, где «не стыкуются» края наружной косой мышца живота и широчайшей мышцы спины называется:

- 1) поясничным пространством Лесгафта-Грюнфельда;
- 2) поясничным треугольником Пти.**

9.479 (УНПО) Поясничный треугольник Пти в сравнении с поясничным пространством Лесгафта-Грюнфельда расположен:

- 1) поверхностнее;**
- 2) глубже.

9.480 (УНВПО) В пределах латерального отдела поясничной области второй мышечный слой составляют:

- 1) наружная косая мышца живота;
- 2) внутренняя косая мышца живота;**
- 3) задняя нижняя зубчатая мышца;**
- 4) задняя верхняя зубчатая мышца.

9.481 (УНПО) Поясничное пространство образуется между:

- 1) широкой мышцей спины и наружной косой мышцей живота;
- 2) наружной косой мышцей живота и задней верхней зубчатой мышцей;
- 3) задней нижней зубчатой мышцей и наружной косой мышцей живота;
- 4) **задней нижней зубчатой мышцей и внутренней косой мышцей живота.**

9.482 (УНПО) Нижней стороной поясничного пространства Лесгафта-Грюнфельда является:

- 1) латеральный край выпрямителя спины;
- 2) нижний край нижней зубчатой мышцы;
- 3) **задний край внутренней косой мышцы живота;**
- 4) XII ребро.

9.483 (УНПО) Поясничное пространство имеет четырёхугольную форму, если сверху прилежит:

- 1) край широчайшей мышцы спины;
- 2) нижний край нижней зубчатой мышцы;
- 3) **XII ребро.**

9.484 (УНВПО) Гнойники забрюшинной клетчатки могут проходить через слабые места поясничной области:

- 1) треугольник Пти;
- 2) **четырёхугольник Лесгафта-Грюнфельда;**
- 3) щель Морганьи;
- 4) **щели Бохдалека.**

9.485 (УНВПО) Дном поясничного пространства Лесгафта-Грюнфельда не является:

- 1) **внутренняя косая мышца живота;**
- 2) **поперечная фасция живота;**
- 3) апоневроз поперечной мышцы живота.

9.486 (УНПО) Самым податливым участком задней брюшной стенки является:

- 1) апоневроз поперечной мышцы живота;
- 2) поясничный треугольник;
- 3) **поясничное пространство;**
- 4) все варианты верны;
- 5) все варианты не верны.

9.487 (УНПО) В апоневрозе поперечной мышцы живота для прохождения сосудов и нервов:

- 1) **есть отверстия;**
- 2) нет отверстий.

9.488 (УНПО) Подреберные сосуды и нерв проходят:

- 1) через отверстия на дне поясничного треугольника;
- 2) через межпозвоночные отверстия;
- 3) **через отверстия в апоневрозе поперечной мышцы живота.**

9.489 (УНВПО) Первый мышечный слой латерального отдела поясничной области составляют:

- 1) выпрямитель спины;
- 2) квадратная мышца поясницы;
- 3) задняя нижняя зубчатая мышца;
- 4) задняя верхняя зубчатая мышца;
- 5) **наружная косая мышца живота;**
- 6) **широчайшая мышца спины.**

9.490 (УНПО) К мышцам медиального отдела поясничной области относятся:

- 1) квадратная мышца поясницы;
- 2) большая поясничная мышца;
- 3) выпрямитель спины;
- 4) все варианты верны;**
- 5) все варианты не верны.

9.491 (УНПО) Забрюшинное пространство является частью полости живота:

- 1) да;**
- 2) нет.

9.492 (УНПО) Широчайшая мышца спины относится к мышцам латерального отдела:

- 1) да;**
- 2) нет.

9.493 (УНПО) Дно поясничного пространства Лесгафта-Грюнфельда составляет:

- 1) поперечная фасция;
- 2) фасция большой поясничной мышцы;
- 3) поперечная мышца;**
- 4) внутренняя косая мышца живота;
- 5) задняя нижняя зубчатая мышца.

9.494 (УНПО) Апоневроз поперечной мышцы живота является продолжением:

- 1) глубокого листка грудопоясничной фасции;**
- 2) поверхностного листка грудопоясничной фасции;
- 3) поперечной фасции живота.

9.495 (УНПО) Пояснично-реберная связка формируется за счет сухожильных элементов:

- 1) внутренней косой мышцы живота;
- 2) поперечной мышцы живота;**
- 3) задней нижней зубчатой мышцы;
- 4) всё неверно.

9.496 (УНПО) Пояснично-реберная связка натянута между:

- 1) первым поясничным позвонком и передней верхней остью подвздошной кости;
- 2) XII ребром и гребнем подвздошной кости;
- 3) первым поясничным позвонком и XII ребром.**

9.497 (УНПО) Поперечная фасция является производной:

- 1) грудопоясничной фасции;
- 2) внутрибрюшной фасции.**

9.498 (УНПО) В латеральном отделе поперечная фасция покрывает:

- 1) квадратную мышцу поясницы;
- 2) апоневроз поперечной мышцы живота;**
- 3) широчайшую мышцу спины.

9.499 (УНПО) В медиальном отделе поперечная фасция покрывает:

- 1) апоневроз поперечной мышцы живота;

- 2) квадратную мышцу поясницы;
- 3) широчайшую мышцу спины.

9.500 (УНПО) Вверху между квадратной мышцей поясницы и одноименной фасцией проходит:

- 1) подреберный нерв;
- 2) подвздошно-подчревный нерв;
- 3) подвздошно-паховый нерв.

9.501 (УНВПО) Внизу между квадратной мышцей поясницы и одноименной фасцией проходят:

- 1) подвздошно-паховый нерв;
- 2) подреберный нерв;
- 3) подвздошно-подчревный нерв.

9.502 (УНВПО) Медиальная и латеральная реберно-поясничные дуги образуются из:

- 1) поперечной фасции;
- 2) фасции большой поясничной мышцы;
- 3) фасции квадратной мышцы поясницы;
- 4) грудопоясничной фасции.

9.503 (УНВПО) К слабым местам в диафрагме относится все перечисленное, кроме:

- 1) поясничного треугольника Пти;
- 2) щелей Бохдалека;
- 3) поясничного пространства Лесгафта-Грюнфельда;
- 4) щели Морганьи;
- 5) щели Ларрея.

9.504 (УНПО) Гнойный воспалительный процесс может перейти с забрюшинной клетчатки на плевру:

- 1) да;
- 2) нет.

9.505 (УНВПО) Позадипочечная фасция расщепляется на два листка у:

- 1) верхнего полюса почки;
- 2) нижнего полюса почки;
- 3) наружного края почки;
- 4) внутреннего края почки.

9.506 (УНПО) Позадипочечная фасция делит забрюшинное пространство на:

- 1) верхний и нижний отделы;
- 2) правый и левый отделы;
- 3) задний и передний отделы.

9.507 (УНВПО) В заднем отделе забрюшинного пространства расположено все перечисленное, за исключением:

- 1) почки и надпочечники;
- 2) аорта;
- 3) нижняя полая вена;
- 4) солнечное сплетение;
- 5) мочеточники.

9.508 (УНВПО) В переднем отделе забрюшинного пространства расположено:

- 1) солнечное сплетение;

- 2) **почки и надпочечники;**
- 3) начало грудного лимфатического протока;
- 4) нижняя полая вена;
- 5) **мочеточники;**
- 6) аорта.

9.509 (УНПО) Второй слой забрюшинной клетчатки находится под:

- 1) внутрибрюшной фасцией;
- 2) забрюшинной фасцией;
- 3) **позадипочечной фасцией.**

9.510 (УНПО) Первый слой забрюшинной клетчатки находится под:

- 1) **внутрибрюшной фасцией;**
- 2) предпочечной фасцией;
- 3) позадипочечной фасцией.

9.511 (УНПО) Третий слой забрюшинной клетчатки находится под:

- 1) внутрибрюшной фасцией;
- 2) **предпочечной фасцией;**
- 3) позадипочечной фасцией.

9.512 (УНПО) Третий слой забрюшинной клетчатки называется:

- 1) околопочечный;
- 2) **околокишечный;**
- 3) околомочеточниковый;
- 4) собственно забрюшинный.

9.513 (УНПО) Околокишечная клетчатка располагается между фасцией Тольдти и:

- 1) предпочечной фасцией;
- 2) предмочеточниковой фасцией;
- 3) **оба варианта верны;**
- 4) оба варианта не верны.

9.514 (УНПО) Гной при воспалении поясничной мышцы может распространяться:

- 1) на бедро;
- 2) в ягодичную область;
- 3) в седалищно-прямокишечную ямку;
- 4) могут быть вторичные затёки в паховый канал;
- 5) **все варианты верны.**

9.515 (УНПО) Скелетотопические характеристики левой почки:

- 1) **от середины XI грудного до верхнего края III поясничного позвонка;**
- 2) от нижнего края XI грудного до середины III поясничного позвонка;
- 3) от XII грудного до середины III поясничного позвонка;
- 4) от верхнего края XI до нижнего края III поясничного позвонка;
- 5) от X грудного до II поясничного позвонка.

9.516 (УНПО) Скелетотопические характеристики правой почки:

- 1) от середины XI грудного до верхнего края III поясничного позвонка;
- 2) **от нижнего края XI грудного до середины III поясничного позвонка;**
- 3) от XII грудного до середины III поясничного позвонка;

- 4) от верхнего края XI до нижнего края III поясничного позвонка;
- 5) от X грудного до II поясничного позвонка.

9.517 (УНПО) Левая почка соприкасается:

- 1) с печенью, правым изгибом ободочной кишки, надпочечником, 12-перстной кишкой;
- 2) с желудком, хвостом поджелудочной железы, петлями тощей кишки, селезёнкой, левым изгибом ободочной кишки, надпочечником;
- 3) с поджелудочной железой, селезёнкой, 12-перстной кишкой, надпочечником, подвздошной кишкой, правым изгибом ободочной кишки;
- 4) с желудком, 12-перстной кишкой, надпочечником, печенью, левым изгибом ободочной кишки.

9.518 (УНПО) Правая почка соприкасается:

- 1) с печенью, правым изгибом ободочной кишки, надпочечником, 12-перстной кишкой;
- 2) с желудком, поджелудочной железой, петлями тощей кишки, селезёнкой, левым изгибом ободочной кишки, надпочечником;
- 3) с желудком, 12-перстной кишкой, надпочечником, печенью, левым изгибом ободочной кишки;
- 4) с поджелудочной железой, селезёнкой, 12-перстной кишкой, надпочечником, подвздошной кишкой, правым изгибом ободочной кишки.

9.519 (УНПО) «Передняя почечная точка» располагается в углу между:

- 1) наружным краем разгибателя туловища и XII ребром;
- 2) наружным краем прямой мышцы живота и рёберной дугой (возле переднего края IX рёберного хряща).

5.520 (УНПО) «Задняя почечная точка» располагается в углу между:

- 1) наружным краем разгибателя туловища и XII ребром;
- 2) наружным краем прямой мышцы живота и рёберной дугой (возле переднего края IX рёберного хряща).

9.521 (УНПО) Почки по отношению к брюшине расположены:

- 1) интраперитонеально;
- 2) экстраперитонеально;
- 3) мезоперитонеально.

9.522 (УНПО) Правая почечная артерия проходит позади:

- 1) хвоста поджелудочной железы;
- 2) нижней полой вены;
- 3) нисходящей части 12-перстной кишки.

9.523 (УНПО) Левая почечная артерия проходит позади:

- 1) нижней полой вены;
- 2) хвоста поджелудочной железы;
- 3) нисходящей части 12-перстной кишки.

9.521 (УНПО) Главным источником нервов почечного сплетения является:

- 1) верхний почечно-аортальный симпатический узел;
- 2) нижний почечно-аортальный симпатический узел;
- 3) оба варианта верны;
- 4) оба варианта не верны.

9.522 (УНВПО) Отток лимфы от почек осуществляется по лимфатическим сосудам, впадающих в узлы расположенные:

- 1) **вокруг нижней поллой вены;**
- 2) **вокруг воротной вены;**
- 3) **вокруг брюшной аорты.**

9.523 (УНВПО) Надпочечники располагаются на уровне:

- 1) **X грудного позвонка;**
- 2) **XI грудного позвонка;**
- 3) **I поясничного позвонка;**
- 4) **XII грудного позвонка.**

9.524 (УНПО) Мочеточники проецируются на переднюю брюшную стенку на уровне пупка:

- 1) **по внутреннему краю прямой мышцы живота;**
- 2) **по наружному краю прямой мышцы живота;**
- 3) **на середине прямой мышцы живота.**

9.525 (УНПО) Диаметр мочеточника в среднем составляет:

- 1) **2-3 мм;**
- 2) **4-5 мм;**
- 3) **5-10 мм;**
- 4) **10-15 мм.**

9.526 (УНПО) Длина мочеточника у мужчин в среднем составляет:

- 1) **27-30 см;**
- 2) **30-32 см;**
- 3) **29-30 см.**

9.527 (УНПО) Длина мочеточника у женщин в среднем составляет:

- 1) **30-32 см;**
- 2) **27-30 см;**
- 3) **27-29 см.**

9.528 (УНПО) У пограничной линии таза левый мочеточник пересекает:

- 1) **общую подвздошную артерию;**
- 2) **наружную подвздошную артерию;**
- 3) **внутреннюю подвздошную артерию.**

9.529 (УНПО) У пограничной линии таза правый мочеточник пересекает:

- 1) **общую подвздошную артерию;**
- 2) **наружную подвздошную артерию;**
- 3) **внутреннюю подвздошную артерию.**

9.530 (УНПО) Кнутри от правого мочеточника проходит:

- 1) **аорта;**
- 2) **нижняя полая вена;**
- 3) **оба варианта не верны.**

9.531 (УНПО) Кнутри от левого мочеточника проходит:

- 1) **аорта;**

- 2) нижняя полая вена;
- 3) оба варианта не верны.

9.532 (УНПО) Кнаружи от левого мочеточника располагаются:

- 1) медиальный край восходящей части ободочной кишки;
- 2) **медиальный край нисходящей части ободочной кишки.**

9.533 (УНПО) Кнаружи от правого мочеточника располагается:

- 1) **медиальный край восходящей части ободочной кишки;**
- 2) медиальный край нисходящей части ободочной кишки.

9.534 (УНПО) К париетальным ветвям брюшной аорты относятся:

- 1) средние надпочечниковые, почечные, яичковые (яичниковые);
- 2) чревный ствол, верхние и нижние брыжеечные артерии;
- 3) **нижние диафрагмальные, поясничные артерии, срединная артерия крестца;**
- 4) средние надпочечниковые, нижние диафрагмальные и поясничные артерии;
- 5) поясничные, верхние и нижние брыжеечные артерии.

9.535 (УНПО) Непарными висцеральными ветвями брюшной аорты являются:

- 1) **чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии;**
- 2) нижние диафрагмальные, поясничные артерии;
- 3) поясничные, верхняя и нижняя брыжеечные артерии;
- 4) средние надпочечниковые, почечные, яичковые (яичниковые);
- 5) нижние диафрагмальные, поясничные и средние надпочечниковые артерии.

9.536 (УНПО) К парным висцеральным ветвям брюшной аорты относятся:

- 1) **средние надпочечниковые, почечные, яичковые (яичниковые) артерии;**
- 2) поясничные, верхняя и нижняя брыжеечные артерии;
- 3) средние надпочечниковые, нижние диафрагмальные и поясничные артерии;
- 4) чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии;
- 5) нижние диафрагмальные, поясничные артерии.

9.537 (УНПО) От чревного ствола отходят:

- 1) верхняя брыжеечная, общая печёночная и селезёночная артерии;
- 2) собственная печёночная, левая желудочная и желудочно-двенадцатиперстная артерии;
- 3) **общая печёночная, левая желудочная и селезёночная артерии;**
- 4) правая желудочная, селезёночная и общая печёночная артерии.

9.538 (УНПО) Средние надпочечниковые артерии берут начало от:

- 1) почечных артерий;
- 2) нижних диафрагмальных артерий;
- 3) **брюшной аорты;**
- 4) верхней брыжеечной артерии;
- 5) чревного ствола.

9.539 (УНПО) Верхние надпочечниковые артерии берут начало от:

- 1) почечных артерий;
- 2) брюшной аорты;
- 3) **нижней диафрагмальной артерии;**
- 4) верхней брыжеечной артерии;

5) селезёночной артерии.

9.540 (УНПО) Поясничные артерии отходят от аорты на уровне тел позвонков:

- 1) XII грудного-I поясничного;
- 2) III-IV поясничных;
- 3) **I-IV поясничных;**
- 4) I-II поясничных.

9.541 (УНПО) Солнечное сплетение проецируется на переднюю брюшную стенку в:

- 1) правой подреберной области;
- 2) левой подреберной области;
- 3) **собственно надчревной области;**
- 4) пупочной области.

9.542 (УНВПО) Длинными ветвями поясничного сплетения являются все перечисленные, за исключением:

- 1) подвздошно-подчревного нерва;
- 2) подвздошно-пахового нерва;
- 3) бедренно-полового нерва;
- 4) **заднего кожного нерва бедра;**
- 5) запирающего нерва;
- 6) седалищного нерва.

9.543 (УНВПО) Хирургические доступы к почкам проводятся по способам:

- 1) Пирогова;
- 2) **Федорова;**
- 3) Кейя;
- 4) Бергмана-Израэля.

9.544 (УНПО) Паранефральную блокаду по А.В. Вишневскому проводят с использованием:

- 1) 0,5 % раствора новокаина;
- 2) **0,25 % раствора новокаина;**
- 3) 0,1 % раствора новокаина.

9.545 (УНПО) При паранефральной блокаде по А.В. Вишневскому возможно ошибочное введение иглы:

- 1) в ободочную кишку;
- 2) в почечную артерию;
- 3) в нижнюю полую вену;
- 4) в печень;
- 5) **все варианты верны.**

9.546 (УНПО) Для обнажения мочеточника в нижней трети используется доступ по способу:

- 1) Бергмана-Израэля;
- 2) **Пирогова;**
- 3) Фёдорова.

9.547 (УНВПО) Для обнажения тазового отдела мочеточника рекомендуется разрез по:

- 1) **Пирогову;**
- 2) **Кэйю;**
- 3) Федорову.

9.548 (УНВПО) Для обнажения мочеточника в верхнем и среднем отделах рекомендуются доступы по:

- 1) Пирогову;
- 2) Кэйю;
- 3) Фёдорову;
- 4) Бергману-Израэлю.

9.549 (УНВПО) При восстановлении анатомической целостности мочеточника его сшивают:

- 1) узловыми швами;
- 2) непрерывным швом;
- 3) П-образными швами;
- 4) скорняжным швом.

9.550 (УНВПО) У новорожденных детей слабо выражена или вообще отсутствует:

- 1) собственная клетчатка забрюшинного пространства;
- 2) околопочечная клетчатка;
- 3) околокишечная клетчатка.

9.551 (УНПО) Скелетотопические характеристики левой почки у новорожденных:

- 1) XII грудной – IV поясничный позвонки;
- 2) нижний край XII грудного – верхний край V поясничного позвонка.

9.552 (УНПО) Размеры почек увеличиваются вдвое:

- 1) на 1-ом году жизни ребёнка;
- 2) на протяжении первых 7 лет жизни ребенка.

9.553 (УНВПО) Для почек новорожденных детей характерно:

- 1) относительно большие размеры;
- 2) небольшие размеры;
- 3) дольчатое строение;
- 4) сглаженная поверхность;
- 5) округлая форма на поперечном разрезе;
- 6) уплощенная форма на поперечном разрезе.

9.554 (УНПО) У детей с возрастом почки смещаются:

- 1) в каудальном направлении;
- 2) в краниальном направлении.

9.555 (УНПО) Мочеточники по отношению к брюшине расположены:

- 1) интраперитонеально;
- 2) мезоперитонеально;
- 3) экстраперитонеально;
- 4) мезоперитонеально и экстраперитонеально;
- 5) мезоперитонеально и интраперитонеально.

9.556 (УНВПО) В пределах почки выделяют все сегменты, за исключением:

- 1) переднего;
- 2) верхнего полюсного;
- 3) среднего;
- 4) нижнего полюсного;
- 5) заднего;
- 6) верхнего предлоханочного;
- 7) нижнего предлоханочного;